



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA
KESEHATAN LAIN
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2026**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN
RS PRIMA HUSADA
TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pelayanan penunjang medis, keteknisian medis, dan terapi fisik yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Lain merupakan komponen esensial dalam sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang memiliki dampak langsung terhadap ketepatan diagnosis, efektivitas terapi, mutu pelayanan, serta keselamatan pasien. Sebagai profesional pemberi asuhan dan penunjang klinis, staf Tenaga Kesehatan Lain (Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian, Radiografer, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Dietisien/Nutrisionis, Perekam Medis, dan Fisioterapis) berkontribusi besar dalam memastikan bahwa setiap rantai pelayanan diberikan secara aman, tepat waktu, akurat, dan sesuai standar profesi masing-masing. Mutu pelayanan yang baik mencerminkan profesionalisme staf serta berpengaruh signifikan terhadap citra klinis dan keberhasilan akreditasi rumah sakit.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemantauan indikator mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Prima Husada Sukorejo dalam beberapa bulan terakhir, masih ditemukan sejumlah permasalahan pada lini pelayanan yang memerlukan perhatian khusus dan perbaikan berkelanjutan. Di antaranya adalah keterlambatan waktu tunggu pelayanan obat racikan di Instalasi Farmasi pada jam-jam sibuk, insiden keterlambatan penyerahan atau kesalahan distribusi berkas rekam medis ke beberapa unit poliklinik rawat jalan, serta waktu tunggu dimulainya tindakan terapi fisik di unit Fisioterapi yang masih melebihi standar akibat antrean pasien yang menumpuk. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan bagian dari indikator mutu prioritas pelayanan, karena berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa perpanjangan waktu tunggu total pasien, risiko kesalahan identifikasi, hambatan kelancaran pelayanan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), serta menurunkan tingkat kepuasan pasien dan keluarga.

Masalah keterlambatan pelayanan obat racikan sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingginya volume resep yang masuk secara bersamaan, kompleksitas proses pengolahan/pencampuran sediaan obat, keterbatasan sarana prasarana peracikan, atau belum optimalnya alur distribusi obat jadi ke pasien. Sementara itu, kendala dalam distribusi berkas rekam medis dapat terjadi akibat beban kerja petugas yang tinggi, proses pencarian berkas manual yang membutuhkan waktu lama, belum optimalnya kepatuhan pengembalian berkas dari ruangan, atau kendala transisi pada sistem integrasi data rekam medis elektronik. Di sisi lain, keterlambatan pada unit Fisioterapi dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah tempat tidur terapi (treatment bed), rasio ketersediaan alat modalitas terapi yang belum sebanding dengan lonjakan pasien, serta pengaturan jadwal kunjungan pasien yang belum terurai dengan baik. Seluruh isu strategis tersebut mencerminkan perlunya peningkatan pengawasan, pembinaan mutu profesi, dan penegakan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang konsisten di seluruh lini Tenaga Kesehatan Lain.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tata kelola profesi kesehatan kini mengalami reformasi besar, salah

satunya melalui pemberlakuan Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup yang diimbangi dengan penguatan kontrol mutu klinis melalui pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang ketat untuk perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) setiap 5 (lima) tahun. Guna menjalankan amanat undang-undang tersebut serta memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES), Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) memiliki tanggung jawab mutlak dalam pelaksanaan fungsi kredensial berbasis kompetensi riil, pemeliharaan mutu profesi melalui audit klinis, serta penegakan etika dan disiplin profesi staf. Fungsi pemeliharaan mutu profesi dilaksanakan secara sistematis melalui audit penunjang medis dan terapi, pemantauan kepatuhan SPO, Evaluasi Kinerja Profesional Berkelanjutan (EKPB), serta penyelenggaraan Diskusi Refleksi Kasus (DRK).

Berdasarkan hal tersebut, Komite Tenaga Kesehatan Lain RS Prima Husada Sukorejo perlu menyusun program kerja komprehensif yang berfokus pada peningkatan mutu profesi, khususnya dalam menekan angka keterlambatan pelayanan obat racikan, meningkatkan efisiensi tata kelola berkas rekam medis, serta mempercepat waktu respons pelayanan terapi fisik. Program kerja ini diharapkan mampu:

1. Memperkuat penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan dan kepatuhan terhadap Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) di unit Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Gizi, Rekam Medis, dan Fisioterapi.
2. Meningkatkan kompetensi, akurasi teknis, dan tanggung jawab individu staf Tenaga Kesehatan Lain dalam pelaksanaan tindakan diagnostik, terapeutik, maupun rehabilitatif.
3. Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi mutu profesi berbasis indikator mutu klinik penunjang dan terapi yang terintegrasi dengan program mutu rumah sakit. Mendorong budaya mutu, keterbukaan ilmiah, dan keselamatan pasien di lingkungan kerja.

Dengan terlaksananya program kerja ini, diharapkan mutu pelayanan Tenaga Kesehatan Lain di RS Prima Husada Sukorejo dapat meningkat secara berkesinambungan, kendala keterlambatan pelayanan dapat diminimalkan ke batas standar, serta kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan rumah sakit dapat terus terjaga dengan prima.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES).
5. Peraturan Menteri Kesehatan penunjang masing-masing rumpun profesi Tenaga Kesehatan Lain yang terkait :
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik.
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik.

- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Program kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) ini disusun sebagai pedoman operasional dan acuan baku dalam pelaksanaan fungsi serta kegiatan komite di rumah sakit. Khususnya, program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan penunjang medis dan keteknisian medis melalui optimalisasi kegiatan kredensialing berbasis kompetensi riil, pemeliharaan mutu profesi melalui audit klinis penunjang, serta pembinaan etika dan disiplin profesi staf Tenaga Kesehatan Lain.

2. Tujuan Umum

Meningkatkan mutu pelayanan penunjang medik di RS Prima Husada secara berkesinambungan melalui pelaksanaan fungsi Komite Tenaga Kesehatan Lain, yaitu kredensial, pemeliharaan mutu profesi, serta pembinaan etika dan disiplin profesi, guna mewujudkan pelayanan klinis yang aman, akurat, tepat waktu, profesional, dan berorientasi penuh pada keselamatan pasien.

3. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan di seluruh unit rumah sakit melalui penekanan pada ketepatan waktu tunggu pelayanan obat racikan di Farmasi, kecepatan distribusi berkas Rekam Medis ke unit rawat jalan, serta ketepatan waktu pelayanan tindakan di Fisioterapi.
- b. Menjamin legalitas, kompetensi, dan profesionalisme staf KTKL melalui kegiatan kredensial, rekredensial, dan verifikasi dokumen STR seumur hidup serta SIP secara berkala sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- c. Menurunkan angka insiden keselamatan pasien pada lini pelayanan (seperti kesalahan identifikasi sampel laboratorium, kesalahan posisi radiografi, kesalahan pemberian diet gizi, atau insiden cedera sendi/otot pada saat tindakan terapi fisik) melalui peningkatan kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO).
- d. Mengembangkan budaya mutu, keterbukaan ilmiah, dan keselamatan pasien di lingkungan kerja seluruh rumpun profesi Tenaga Kesehatan Lain.
- e. Meningkatkan efektivitas pengawasan mutu profesi melalui pelaksanaan audit klinis, Diskusi Refleksi Kasus (DRK), dan Evaluasi Kinerja Profesional Berkelanjutan (EKPB) secara periodik.
- f. Memperkuat koordinasi dan komunikasi integratif antara Komite Tenaga Kesehatan Lain, jajaran manajemen rumah sakit, kepala instalasi unit pelayanan, serta profesional pemberi asuhan lainnya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 VISI

“Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat”

2.2 MISI

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

2.3 MOTTO

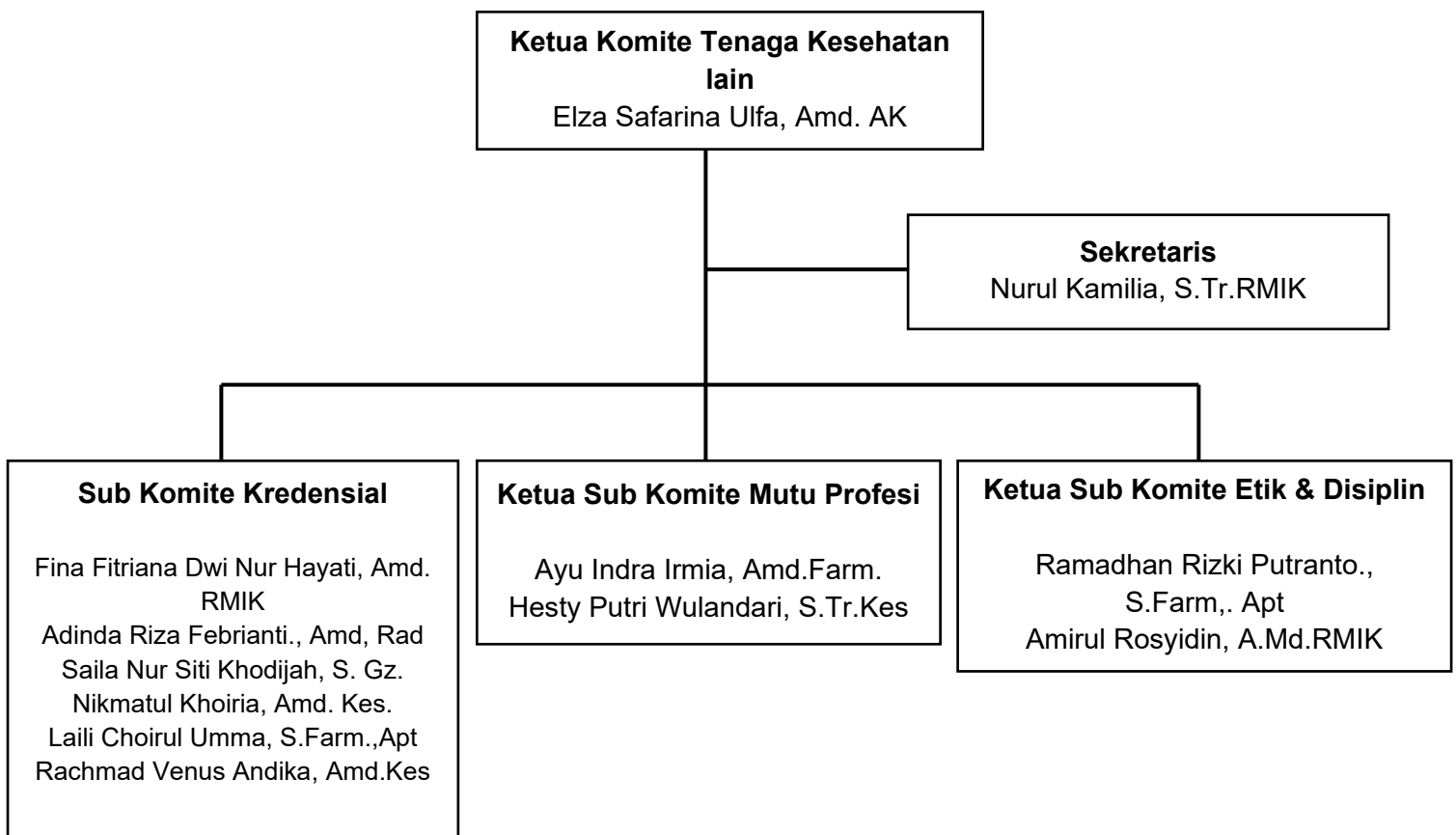
“Sahabat menuju sehat”

2.4 (7) NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur dipercaya
2. Tanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN RS PRIMA HUSADA SUKOREJO



BAB III

KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

Tabel 3.1.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
A. Sub Komite Kredensial		
1	Pelaksanaan Kredensial Staf KTKL Baru	a. Mengumpulkan dan memverifikasi dokumen (STR, Ijazah, Sertifikat pelatihan, pengalaman kerja, evaluasi kinerja) b. Wawancara/ assesmen kompetensi awal c. Penilaian kompetensi klinis berbasis unit d. Menyusun rekomendasi kelayakan kredensial
2	Penetapan kewenangan klinis	a. Menyusun daftar kewenangan klinis berdasarkan kompetensi dan area praktik b. Melaksanakan kredensial c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk penerbitan SK kewenangan klinis d. Sosialisasi kewenangan klinis ke unit kerja
3	Re-Kredensial/ perpanjangan kewenangan klinis	a. Mengevaluasi logbook / realisasi tindakan b. Review pelatihan / pendidikan lanjutan c. Menilai catatan insiden keselamatan pasien / aduan pasien d. Merekomendasikan perpanjangan, pembatasan, atau pencabutan kewenangan
4	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kewenangan Klinis	a. Audit kepatuhan kewenangan klinis di unit b. Supervisi penerapan SOP klinis sesuai kompetensi c. Pembinaan jika ditemukan pelanggaran kewenangan d. Merekomendasikan pelatihan tambahan pada gap kompetensi
B. Sub Komite Mutu Profesi		
1	Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Klinis KTKL	a. Menyusun instrumen dan kriteria audit klinis khusus untuk masing-masing rumpun profesi (Farmasi, Fisioterapis, Laboratorium, Radiologi, Gizi, dan Rekam Medis). b. Melaksanakan Audit Mutu Kefarmasian secara berkala yang difokuskan pada analisis hambatan dan pemangkasan alur sediaan guna menurunkan waktu tunggu pelayanan obat racikan pada jam sibuk. c. Melaksanakan Audit Tata Kelola Rekam Medis secara periodik dengan fokus pada kepatuhan <i>retrieval</i> berkas, kelengkapan pengisian, serta kecepatan waktu distribusi berkas rekam medis ke poliklinik rawat jalan. d. Melaksanakan Audit Mutu Fisioterapi secara periodik yang difokuskan pada ketepatan waktu respons dimulainya tindakan terapi fisik serta efektivitas pemanfaatan alat modalitas terapi. e. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) tindakan

		teknis diagnostik di unit Laboratorium dan Radiologi. f. Menganalisis data hasil audit, merumuskan rekomendasi perbaikan sistem, dan menyusun rencana tindak lanjut (RTL) bersama Kepala Instalasi terkait untuk diserahkan kepada Direktur.
2	Penyelenggaraan Forum Ilmiah dan Pembinaan Mutu (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)	a. Melakukan pemetaan kesenjangan kompetensi teknis klinis staf KTKL berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. b. Memfasilitasi dan menjadwalkan kegiatan ilmiah internal seperti <i>Case Report</i> (Laporan Kasus), <i>Journal Reading</i> (Telaah Jurnal), seminar mini, atau <i>Internal Workshop</i> lintas profesi penunjang. c. Menyenggarakan Diskusi Refleksi Kasus (DRK) minimal 2 kali dalam setahun untuk membahas insiden klinis, kasus sulit, atau area pelayanan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. d. Membantu koordinasi dengan Bagian Diklat Rumah Sakit dalam memfasilitasi diklat internal yang terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan untuk mempercepat pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) staf melalui portal resmi (Pelataran Sehat).
3	Pembinaan Praktik Profesional dan Kepatuhan SOP	a. Sosialisasi dan Internalisasi Standar Prosedur Operasional (SPO) Klinis Terintegrasi b. Pelaksanaan Supervisi Klinis Berkala dan Audit Kepatuhan Lapangan c. Evaluasi Praktik Profesional Berkelanjutan (EKPB) d. Tindak Lanjut Pembinaan dan Konseling Praktik Klinis bagi staf yang mengalami penurunan kinerja atau ketidakpatuhan prosedur.
4	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien & Budaya Keselamatan	a. Melakukan pemantauan berkala terhadap kepatuhan pelaksanaan identifikasi pasien (SKP 1) secara ketat sebelum pengambilan sampel darah di Laboratorium, paparan radiasi di Radiologi, penyerahan obat di Farmasi, maupun sebelum pemberian tindakan terapi fisik di Fisioterapi. b. Memantau kepatuhan penerapan komunikasi efektif menggunakan metode Tulis, Baca Kembali, dan Konfirmasi (TulBaKon) saat pelaporan nilai kritis laboratorium oleh ATLM, instruksi verbal obat kedaruratan oleh Apoteker, atau instruksi pembatasan gerak/fase pemulihan pasca-operasi oleh Fisioterapis. c. Mengidentifikasi, mencatat, dan mengkaji setiap kejadian insiden keselamatan pasien—baik Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), maupun Kejadian Potensial Cedera (KPC)—yang terjadi di lingkup

		pelayanan penunjang medis sebagai bahan evaluasi mutu profesi.
C. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi		
1	Pembinaan Etika Profesional dan Perilaku Klinis	a. Menyusun dan memperbarui panduan perilaku profesional (<i>Code of Conduct</i>) yang diselaraskan dengan etika profesi masing-masing rumpun Tenaga Kesehatan Lain (Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian, Radiografer, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Dietisien/Nutrisisionis, Perekam Medis, dan Fisioterapis) b. Melaksanakan sosialisasi berkala mengenai kode etik profesi dan orientasi budaya pelayanan prima berbasis keselamatan pasien c. Menyenggarakan forum edukasi preventif mengenai batasan hukum dan disiplin profesi guna mencegah terjadinya malpraktik atau kelalaian teknis di unit penunjang dan terapi. d. Memberikan layanan konseling dan pembinaan dini bagi staf Tenaga Kesehatan Lain yang teridentifikasi mengalami penurunan kinerja perilaku atau menunjukkan tanda-tanda masalah hubungan antar-pribadi di lingkungan kerja.
2	Pencegahan Pelanggaran Etika dan Disiplin	a. Melaksanakan sosialisasi berkala mengenai Kode Etik Profesi masing-masing rumpun tenaga kesehatan lain (Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian, Radiografer, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Dietisien/Nutrisisionis, Perekam Medis, dan Fisioterapis). b. Menyenggarakan forum edukasi preventif mengenai batasan kewenangan klinis dan aspek hukum pelayanan guna mencegah terjadinya kelalaian teknis di unit kerja. c. Memberikan layanan konseling preventif dan pembinaan dini bagi staf yang menunjukkan indikasi penurunan kinerja perilaku atau ketidakharmonisan hubungan antar-pribadi sebelum berkembang menjadi pelanggaran formal.
3	Penanganan Kasus Pelanggaran Etika & Disiplin	a. Menerima, mencatat, dan menelaah setiap laporan aduan atau komplain dari pasien, keluarga, maupun sesama Profesional Pemberi Asuhan (PPA) terkait perilaku staf penunjang. b. Menentukan kelayakan kasus dan mengklasifikasikan dugaan pelanggaran berdasarkan parameter Matriks Kategorisasi Pelanggaran dengan Nilai Skor (1–100) ke dalam tingkatan: Kelompok I (Ringan), Kelompok II (Sedang), dan Kelompok III (Berat). c. Menggelar Sidang Ad-Hoc penegakan disiplin profesi yang objektif dengan melibatkan pengurus komite dan Mitra Bestari yang sesuai dengan profesi staf terlapor.

4	Investigasi & Rekomendasi Sanksi / Rehabilitasi	a. Melakukan pengumpulan bukti klinis, telaah dokumen catatan logistik tindakan (<i>logbook</i>), sirkulasi berkas rekam medis, pencatatan sediaan obat, atau lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) pelayanan fisioterapi, serta memanggil saksi terkait untuk proses klarifikasi. b. Melaksanakan analisis akar masalah (<i>Root Cause Analysis</i>) terhadap pelanggaran yang terjadi untuk melihat keterkaitan antara kelalaian individu dan sistem kerja rumah sakit. c. Menyusun surat rekomendasi formal kepada Direktur RS Prima Husada Sukorejo mengenai pemberian sanksi profesi (teguran tertulis, pembatasan kewenangan sementara, pendampingan ulang/<i>proctoring</i>) bagi yang terbukti bersalah, atau menerbitkan surat rekomendasi pemulihan nama baik (rehabilitasi profesi) jika staf tidak terbukti melakukan pelanggaran.
5	Monitoring Kepatuhan Etika & Disiplin	a. Melakukan pemantauan harian terhadap kepatuhan staf di unit kerja mengenai kedisiplinan jam dinas dan penggunaan atribut identitas (Kartu Tanda Pengenal) resmi sesuai aturan internal rumah sakit mengenai staf non-medis b. Mengembangkan dan mengevaluasi indikator perilaku profesional staf yang diintegrasikan ke dalam lembar Evaluasi Kinerja Profesional Berkelanjutan (EKPB) setiap 6 bulan sekali. c. Melakukan kunjungan berkala (<i>audit keliling/round audit</i>) ke unit-unit penunjang medis dan Fisioterapi untuk memastikan iklim kerja tetap kondusif dan berjalan sesuai standar etika pelayanan rumah sakit.
6	Komunikasi Efektif	a. Mengadakan pelatihan dan penyegaran tata cara komunikasi efektif bagi staf, khususnya dalam memberikan edukasi instruksi persiapan pra-tindakan kepada pasien (seperti instruksi puasa, penggunaan zat kontras, atau instruksi posisi tubuh dan teknik bernapas pada terapi fisik). b. Membina kemampuan staf Farmasi dalam melakukan Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan konseling kepada pasien/keluarga secara ramah, jelas, dan empatik demi meningkatkan kepuasan pelayanan. c. Memfasilitasi mediasi komunikasi antar-profesi guna mencegah terjadinya salah paham atau konflik horizontal antar-staf maupun dengan profesi medis/keperawatan saat berkoordinasi klinis.
7	Pembuatan kebijakan	a. Menyusun dan memperbarui buku panduan perilaku profesional (<i>Code of Conduct</i>) staf

		Tenaga Kesehatan Lain RS Prima Husada Sukorejo yang diselaraskan dengan regulasi hukum kesehatan terbaru. b. Merumuskan draf Kebijakan Direktur dan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait alur pelaporan, investigasi, dan tata cara persidangan etik staf di rumah sakit. c. Melakukan evaluasi dan revisi berkala terhadap aturan internal staf non-medis agar tetap relevan dengan perkembangan organisasi dan tuntutan Akreditasi Rumah Sakit (STARKES).
--	--	--

3.2 SASARAN

Tabel 3.2.1 Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
A. Sub Komite Kredensial							
1	Pelaksanaan kredensial perawat baru						
	a. Mengumpulkan dan memverifikasi dokumen STR, Ijazah, Sertifikat, Pelatihan, Pengalaman kerja, evaluasi kinerja	Memastikan calon staf tenaga kesehatan lainnya memiliki kualifikasi legal, administratif dan kompetensi minimal.	Seluruh staf baru Tenaga Kesehatan Lain	Administratif	100% dokumen tervalidasi sebelum bekerja (≤ 7 hari)	Persentase kelengkapan & keabsahan dokumen: $(\text{Jumlah calon tenaga kesehatan lainnya dengan dokumen lengkap} \div \text{total staff baru tenaga kesehatan lainnya}) \times 100\%$	
	b. Wawancara/ assesmen kompetensi awal	Menilai kemampuan dasar, pengalaman, dan kesiapan kerja staf baru Tenaga Kesehatan Lain	Seluruh staf baru Tenaga Kesehatan Lain	Asesmen kompetensi awal.	Asesmen dilakukan 100% sebelum penempatan	Persentase staf tenaga kesehatan lainnya yang telah mengikuti assesmen awal.	
	c. Penilaian Kompetensi Klinis Berbasis Unit	Memetakan kompetensi sesuai unit kerja	Staf baru Tenaga Kesehatan Lain yang ditempatkan	Kompetensi klinis	100% staf baru tenaga kesehatan lainnya yang menjalani OJT & uji kompetensi unit	Kompetensi dasar unit dikuasai $\geq 80\%$	
	d. Menyusun Rekomendasi Kelayakan Kredensial	Menetapkan kelayakan pemberian kewenangan klinis	Staf baru Tenaga Kesehatan Lain pasca-penilaian	Administratif	Rekomendasi terbit ≤ 3 hari setelah assesmen	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	
2	Penetapan Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)						

	a. Penyusunan daftar kewenangan klinis berdasarkan kompetensi & area praktik	Menyusun daftar kewenangan sesuai standar pelayanan & kompetensi staf	Sub Komite Kredensial	Administratif	Dokumen kewenangan klinis tersedia & diperbarui 1x/tahun	Dokumen Rincian Kewenangan Klinis yang disahkan Direktur	
	b. Melaksanakan Kredensial	Menilai kesesuaian kompetensi staf dengan kewenangan yang diminta.	Semua staf Tenaga Kesehatan Lain aktif	Kredensial	Kredensial dilaksanakan pada seluruh staf aktif	Persentase staf Tenaga Kesehatan Lain yang dikredensial ulang: 100%	
	c. Memberikan rekomendasi kepada direktur untuk penerbitan SK kewenangan klinis	Menjamin SK ditetapkan berdasarkan asesmen objektif.	Semua staf Tenaga Kesehatan Lain	Administratif	SK terbit $\leq$ 14 hari setelah kredensial	Ketepatan waktu penerbitan Surat Penugasan Klinis	
	d. Sosialisasi kewenangan klinis ke unit kerja	Memastikan kepala ruang memahami kewenangan staf	Semua staf Tenaga Kesehatan Lain	Sosialisasi	Sosialisasi dilakukan 100% ke seluruh unit pelayanan penunjang dan terapi	- Daftar hadir sosialisasi. - Pengetahuan kepala ruang meningkat	
3	Re-Kredensial/ perpanjangan kewenangan klinis						
	a. Mengevaluasi logbook/ realisasi tindakan	Menilai konsistensi, volume, dan mutu tindakan klinis sebagai dasar perpanjangan kewenangan	Seluruh staf Tenaga Kesehatan Lain yang masa kewenangannya akan berakhir	Evaluasi dokumen	100% catatan tindakan (logbook) diverifikasi setiap Tenaga Kesehatan Lain sebelum masa izin berakhir	Persentase logbook yang lengkap dan tervalidasi: $\geq$ 95%	
	b. Review pelatihan/pendidikan lanjutan	Memastikan pemenuhan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Staf Tenaga Kesehatan Lain pemegang kewenangan klinis	Riwayat pelatihan	Semua pelatihan relevan dengan area praktik	100% tenaga memiliki bukti pelatihan yang relevan dalam 12 bulan terakhir	

		untuk perpanjangan kewenangan					
	c. Menilai catatan insiden keselamatan pasien / aduan pasien	Menjamin bahwa Tenaga Kesehatan Lain menjalankan praktik aman dan bebas temuan pelanggaran berat	Staf Tenaga Kesehatan Lain yang akan rekredensial	Telaah insiden dan umpan balik pasien	- Tidak ada insiden sentinel. - Bila ada insiden KNC/NKNC telah dilakukan RCA & pembinaan	- Persentase tenaga yang tidak memiliki insiden berat: 100%. - Semua insiden yang terjadi memiliki tindak lanjut (100% completed)	
	d. Merekomendasikan perpanjangan, pembatasan, atau pencabutan kewenangan	Menjamin kewenangan klinis diberikan sesuai kompetensi aktual.	Seluruh tenaga yang melalui proses rekredensial	Rekomendasi	Rekomendasi diberikan maksimal 30 hari setelah evaluasi	Persentase keputusan yang tepat waktu: $\geq 95\%$	
4	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kewenangan Klinis						
	a. Audit kepatuhan kewenangan klinis di unit	Memastikan setiap tenaga hanya melakukan tindakan sesuai kewenangan	Seluruh unit pelayanan penunjang medis dan Fisioterapi	Audit dokumen, audit tindakan, audit rekam medis	Audit dilakukan minimal 2x/tahun	Kepatuhan terhadap Rincian Kewenangan Klinis (RKK): $\geq 95\%$	
	b. Supervisi penerapan SOP klinis sesuai kompetensi	Menjamin tindakan sesuai SOP dan standar klinis	Staf Tenaga Kesehatan Lain di unit pelayanan	Supervisi langsung, mentoring, coaching.	Supervisi minimal 1x/bulan	Kepatuhan SOP > 90%	
	c. Pembinaan jika ditemukan pelanggaran kewenangan	Memperbaiki praktik dan mencegah pengulangan pelanggaran	Staf Tenaga Kesehatan Lain yang melanggar batasan kewenangan	Konseling	Pembinaan diberikan maksimal 3 hari setelah temuan	- Tidak ada pelanggaran berulang. - Semua pembinaan telah ditindaklanjuti.	

	d. Merekomendasikan pelatihan tambahan pada gap kompetensi	Menutup kesenjangan kompetensi individu maupun unit.	Staf Tenaga Kesehatan Lain yang membutuhkan peningkatan kompetensi	Rencana pelatihan	- Semua gap kompetensi memiliki rencana pelatihan. - Minimal 80% pelatihan terlaksana setiap tahun	Kelulusan pelatihan $\geq$ 95%.	
B. Sub Komite Mutu Profesi							
1	Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Klinis KTKL						
	a. Menyusun instrumen dan kriteria audit klinis khusus untuk masing-masing rumpun profesi	Menyediakan parameter ukur yang valid, objektif, dan baku untuk menilai mutu pelayanan spesifik multi-profesi.	Dokumen mutu internal Komite KTKL RS Prima Husada.	Kebijakan & Regulasi Profesi	Tersedianya 6 dokumen instrumen audit spesifik (1 per rumpun profesi: Farmasi, Lab, Radiologi, Gizi, Rekam Medis, dan Fisioterapi) pada Triwulan I 2026.	Dokumen instrumen audit klinis disahkan oleh Ketua Komite KTKL dan disetujui Manajemen Rumah Sakit.	
	b. Melaksanakan Audit Mutu Kefarmasian secara berkala (fokus obat racikan).	Mengidentifikasi <i>bottleneck</i> alur peracikan guna memangkas durasi penyiapan obat pada jam sibuk (<i>peak hours</i>).	Staf Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) di Instalasi Farmasi.	Telaah Operasional & Kepatuhan SPO	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit di semua sif pelayanan.	$\geq 90\%$ sampel resep obat racikan yang diaudit memenuhi standar waktu tunggu yang ditetapkan.	
	c. Melaksanakan Audit Tata Kelola Rekam Medis secara periodik.	Memastikan kelancaran sirkulasi berkas, ketepatan proses <i>retrieval</i> , dan mencegah hilangnya berkas RM.	Staf Perekam Medis dan Informasi Kesehatan di Unit Rekam Medis.	Evaluasi Dokumen & Efisiensi Alur	Waktu distribusi berkas RM ke poliklinik ≤ 30 menit sebelum jam praktik dokter dimulai.	$\geq 95\%$ berkas rekam medis rawat jalan terdokumentasi dan terdistribusi secara lengkap serta tepat waktu.	

	d. Melaksanakan Audit Mutu Pelayanan Fisioterapi	Memastikan ketepatan waktu pelayanan terapi fisik dan efisiensi penjadwalan guna meminimalkan antrean pasien.	Staf Fisioterapis di Unit Fisioterapi / Rehabilitasi Medik	Evaluasi Alur Pelayanan & Waktu Respons	Waktu tunggu tindakan ≤ 15 menit sejak pasien mendaftar di loket unit Fisioterapi.	$\geq 90\%$ pasien mendapatkan pelayanan terapi fisik tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.	
	e. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap SPO tindakan teknis diagnostik.	Meminimalkan risiko kesalahan klinis pada proses pra-analitik dan paparan tindakan radiasi.	Staf Radiografer (Radiologi) dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik / ATLM (Laboratorium).	Observasi Klinis & Pengawasan Lapangan	Angka kepatuhan identifikasi pasien (SKP 1) dan akurasi teknis mencapai 100% .	Zero accident / Nol insiden salah identifikasi sampel laboratorium dan salah posisi paparan radiasi rontgen.	
	f. Menganalisis data hasil audit dan menyusun <i>Rencana Tindak Lanjut (RTL)</i> .	Merumuskan solusi perbaikan sistem pelayanan penunjang dan memberikan rekomendasi kebijakan bagi manajemen.	Data hasil temuan audit lapangan dan manajemen instalasi terkait.	Administratif & Rekomendasi Klinis	Penyusunan analisis data dan draf rekomendasi CAP diselesaikan maksimal 14 hari pasca-audit.	Dokumen laporan CAP ditandatangani oleh Kepala Instalasi terkait dan diserahkan kepada Direktur Rumah Sakit.	
2	Penyelenggaraan Forum Ilmiah dan Pembinaan Mutu (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)						
	a. Melakukan pemetaan kesenjangan kompetensi teknis klinis	Mengetahui kebutuhan diklat yang riil, spesifik, dan objektif dari setiap staf berdasarkan perkembangan ilmu terbaru.	Profil data kompetensi dan rekam jejak klinis seluruh individu staf fungsional KTKL	Evaluasi Dokumen & Analisis Kompetensi	Pemetaan kompetensi seluruh staf selesai 100% pada awal tahun (Triwulan I 2026).	Tersedianya dokumen matriks kesenjangan kompetensi sebagai dasar penyusunan rencana diklat tahunan.	
	b. Memfasilitasi dan menjadwalkan kegiatan ilmiah internal	Merangsang budaya berpikir kritis, berbasis bukti, serta meningkatkan wawasan klinis lintas profesi.	Seluruh rumpun staf profesi KTKL di bawah naungan komite	Pendidikan & Pengembangan Kompetensi	Terlaksananya forum ilmiah internal minimal 4 kali dalam setahun (1 kali per triwulan).	Sertifikat kegiatan diterbitkan dan forum dihadiri oleh minimal 85% dari total staf fungsional KTKL.	

	c. Menyelenggarakan Diskusi Refleksi Kasus (DRK) secara periodik	Mengevaluasi, menyelesaikan, dan memetik pelajaran klinis dari kasus sulit, kasus langka, atau insiden area rawan.	Kelompok profesi atau staf pada unit pelayanan prioritas	Telaah Insiden & Telaah Sejawat (<i>Peer Review</i>)	Pelaksanaan DRK minimal 2 kali dalam setahun (1 kali per semester).	Terbitnya dokumen Berita Acara DRK yang memuat rekomendasi solusi klinis/teknis penanganan kasus.	
	d. Koordinasi fasilitasi diklat internal terakreditasi Kemenkes	Mempermudah staf dalam pemenuhan batas Satuan Kredit Profesi (SKP) secara digital sesuai amanat UU No. 17/2023.	Akun SatuSehat SDMK / Pelataran Sehat milik staf fungsional KTKL	Administratif & Sinkronisasi Sistem Kemenkes	≥ 90% staf terpantau aktif dan mengalami kemajuan pencapaian SKP di portal resmi.	Seluruh agenda diklat internal KTKL terdaftar resmi pada LMS Kemenkes sehingga poin SKP staf otomatis terintegrasi.	
3	Pembinaan Praktik Profesional dan Kepatuhan SOP						
	a. Sosialisasi dan Internalisasi Standar Prosedur Operasional (SPO) Klinis Terintegrasi	Meningkatkan pemahaman staf terhadap pembaruan SPO pelayanan klinis	Seluruh staf pelaksana fungsional KTKL di unit pelayanan.	Sosialisasi & Internalisasi	Terlaksananya bedah SPO spesifik unit minimal 1 kali setiap triwulan di masing-masing instalasi.	100% staf mengikuti sosialisasi dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti pemahaman tata laksana baku.	
	b. Pelaksanaan Supervisi Klinis Berkala dan Audit Kepatuhan Lapangan	Memantau secara langsung kepatuhan harian staf terhadap pelaksanaan SPO	Seluruh staf pelaksana fungsional KTKL di unit pelayanan.	Observasi Klinis & Pengawasan Lapangan	Angka kepatuhan staf terhadap SPO teknis klinis mencapai ≥ 95%.	Terlaksananya ronde supervisi klinis secara berkala dan terdokumentasi dalam catatan mutu subkomite.	
	c. Evaluasi Kinerja Profesional Berkelanjutan (EKPB)	Menilai performa, kompetensi klinis, dan perilaku staf secara berkala, objektif, dan terukur sebagai dasar	Seluruh staf pelaksana fungsional KTKL di unit pelayanan.	Evaluasi Dokumen & Kompetensi Klinis	Penilaian EKPB dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali (per semester).	100% staf KTKL memiliki dokumen rapor EKPB yang lengkap sebagai syarat kelayakan rekredensial.	

		rekomendasi kewenangan klinis.					
	d. Tindak Lanjut Pembinaan dan Konseling Praktik Klinis	Memberikan koreksi, edukasi ulang, dan pendampingan khusus bagi staf yang mengalami penurunan performa kompetensi atau kepatuhan SPO.	Staf fungsional KTKL yang berdasarkan hasil audit atau laporan insiden memerlukan perbaikan mutu.	Rekomendasi & Pembinaan Praktik	Pelaksanaan program pendampingan (<i>proctoring</i>) diselesaikan maksimal 1 bulan sejak rekomendasi diterbitkan.	Staf yang dibina mampu melampaui batas ambang standar kelayakan klinis pasca-pendampingan dan tidak mengulangi kesalahan serupa.	
4	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien & Budaya Keselamatan						
	a. Melakukan monitoring berkala terhadap kepatuhan pelaksanaan identifikasi pasien (SKP 1)	Mencegah terjadinya kesalahan pasien (<i>wrong patient</i>) sebelum tindakan invasif, penarikan sampel, paparan radiasi, pemberian tindakan terapi fisik, atau penyerahan obat.	Prosedur konfirmasi identitas (Nama & Tanggal Lahir/No. RM) pada setiap pelayanan staf Tenaga Kesehatan Lain.	Observasi Lapangan & Kepatuhan Sasaran Keselamatan	Kepatuhan verifikasi identitas pasien mencapai 100% di seluruh unit pelayanan tanpa toleransi deviasi.	Hasil audit menunjukkan kepatuhan mutlak (<i>Zero Deviance</i>) dan nihil insiden salah pasien di seluruh unit.	
	b. Memantau kepatuhan penerapan komunikasi efektif metode Tulis, Baca Kembali, dan Konfirmasi (TBAK)	Menghindari salah interpretasi instruksi verbal/lisan saat pelaporan hasil diagnostik kritis, instruksi obat darurat, atau instruksi pembatasan gerak pasien.	Alur pelaporan lisan/telepon antara staf penunjang/terapi dengan DPJP atau perawat ruangan.	Audit Komunikasi Klinis & Telaah Dokumen	Kepatuhan konfirmasi balik dan pencatatan nilai kritis terdokumentasi 100% di rekam medis pasien.	Pelaporan nilai kritis laboratorium/radiologi tersampaikan dan terkonfirmasi dalam waktu ≤ 15 menit sejak hasil keluar.	
	c. Mengidentifikasi, mencatat, dan mengkaji setiap kejadian insiden	Melakukan pelacakan dini terhadap kelemahan sistem	Lembar laporan insiden (<i>Incident Report</i>) internal di	Telaah Insiden & Manajemen Risiko	100% insiden keselamatan yang ditemukan wajib	Terlaksananya kajian komprehensif atau investigasi sederhana	

	keselamatan pasien (KNC, KTD, KPC)	pelayanan agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.	seluruh unit rumpun KTKL.		dilaporkan resmi dalam waktu 2x24 jam ke Komite Mutu.	pada setiap laporan insiden untuk penyusunan rekomendasi sistem.	
C. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan							
1	Pembinaan Etika Profesional dan Perilaku Klinis						
	a. Menyusun dan memperbarui panduan perilaku profesional	Menyediakan standar acuan perilaku tertulis yang spesifik bagi multi-rumpun profesi KTKL.	Buku saku/Dokumen <i>Code of Conduct</i> KTKL RS Prima Husada Sukorejo.	Kebijakan & Regulasi Profesi	Tersusunnya 1 dokumen panduan utuh yang mencakup seluruh profesi KTKL di Semester I 2026.	Dokumen panduan perilaku profesional disahkan oleh Direktur RS.	
	b. Melaksanakan sosialisasi berkala kode etik profesi & budaya pelayanan prima	Menanamkan pemahaman etika asuhan dan empati pelayanan untuk menekan angka keluhan pasien.	Seluruh staf pelaksana fungsional KTKL di unit pelayanan.	Sosialisasi & Edukasi	Terlaksananya sosialisasi minimal 2 kali dalam setahun (per semester).	Minimal 85% staf menghadiri sosialisasi dan memahami indikator pelayanan prima.	
	c. Menyelenggarakan forum edukasi preventif mengenai batasan hukum & disiplin	Mencegah terjadinya pelanggaran hukum, kelalaian teknis, atau malpraktik di unit penunjang dan terapi.	Staf fungsional penunjang medis, teknis klinis, dan terapi fisik.	Pendidikan & Pengembangan	Terlaksananya forum edukasi hukum kesehatan 1 kali dalam setahun.	Meningkatnya kesadaran hukum staf dan terciptanya iklim praktik klinis yang aman.	
	d. Layanan konseling dan pembinaan dini bagi staf bermasalah	Menyelesaikan konflik antar-pribadi dan memulihkan penurunan kinerja perilaku secara dini.	Individu staf yang menunjukkan tanda-tanda penurunan performa perilaku.	Rekomendasi & Pembinaan Praktik	Respons dan pelaksanaan konseling diselesaikan maksimal 7 hari setelah laporan unit masuk.	Staf yang dibina menunjukkan perbaikan perilaku yang dinilai melalui lembar pemantauan berkala.	
2	Pencegahan Pelanggaran Etika dan Disiplin						
	a. Melaksanakan sosialisasi berkala mengenai Kode Etik Profesi rumpun nakes	Menyegarkan kembali komitmen staf terhadap sumpah profesi dan	Kelompok profesi (Apoteker/TTK, Radiografer, ATLM,	Sosialisasi & Internalisasi	Terlaksananya pertemuan berkala per	Terwujudnya pemahaman yang seragam mengenai	

		batasan etika masing-masing.	Dietisien, Perekam Medis, dan Fisioterapis).		rumpun profesi 1 kali setahun.	kode etik profesi masing-masing rumpun.	
	b. Forum edukasi preventif batasan kewenangan klinis & aspek hukum	Mencegah staf melakukan tindakan di luar mandat dokumen Rincian Kewenangan Klinis (RKK).	Seluruh staf Tenaga Kesehatan Lain yang memegang Surat Penugasan Klinis (SPK).	Edukasi Regulasi Klinis	Kepatuhan praktik sesuai RKK mencapai 100% di seluruh unit kerja.	Nol kasus (zero case) penyalahgunaan atau pelampauan kewenangan klinis staf.	
	c. Memberikan layanan konseling preventif ketidakharmonisan antar-pribadi	Mencegah konflik horizontal antarstaf meluas hingga mengganggu kelancaran operasional pelayanan pasien.	Hubungan kerja antarstaf internal unit maupun lintas profesi.	Konseling & Manajemen Konflik	Penyelesaian mediasi internal tuntas sebelum masuk ke ranah pelanggaran formal.	Terjaganya kondusivitas, kerja sama tim, dan iklim kerja di unit pelayanan.	
3	Penanganan Kasus Pelanggaran Etika & Disiplin						
	a. Menerima, mencatat, dan menelaah setiap laporan aduan atau keluhan	Menyaring dan mengadministrasikan pengaduan secara profesional dan rahasia.	Berkas laporan aduan dari pasien, keluarga, maupun sesama staf (PPA).	Administratif & Telaah Dokumen	Telaah awal kelayakan laporan diselesaikan dalam waktu maksimal 3×24 jam sejak diterima.	Setiap pengaduan tercatat lengkap di dalam buku registrasi kasus Subkomite Etik & Disiplin.	
	b. Menentukan kelayakan kasus dan klasifikasi menggunakan Matriks Skor (1-100)	Mengukur derajat keparahan pelanggaran secara objektif agar sanksi yang diusulkan bersifat proporsional.	Kasus dugaan pelanggaran yang dinyatakan layak diperiksa.	Kategorisasi & Analisis Kasus	Klasifikasi kasus (Kelompok I, II, III) ditetapkan secara mufakat pada rapat internal.	Adanya lembar penilaian skor pelanggaran yang akurat berbasis matriks disiplin KTKL.	
	c. Menggelar Sidang Khusus (<i>Ad-Hoc</i>) penegakan disiplin profesi yang objektif	Menggali kebenaran materiil secara adil dengan mendengarkan pembelaan staf dan pandangan ilmiah keahlian.	Staf terlapor, saksi-saksi, dan perwakilan pengurus komite beserta Mitra Bestari terkait.	Sidang Klinis & Telaah Sejawat (<i>Peer Review</i>)	Pelaksanaan sidang khusus diselenggarakan sesuai regulasi rumah sakit yang berlaku.	Terlaksananya sidang yang independen bersama Mitra Bestari rumpun terkait.	

4	Investigasi & Rekomendasi Sanksi / Rehabilitasi						
	a. Melakukan pengumpulan bukti klinis dan memanggil saksi	Menjamin proses pembuktian didukung fakta yang kuat (data rekam medis, catatan tindakan, sediaan obat, lembar CPPT fisioterapi, dll.).	Berkas pendukung klinis operasional di unit kerja terkait.	Investigasi & Evaluasi Dokumen	Pengumpulan seluruh alat bukti diselesaikan sebelum sidang khusus digelar.	Terkumpulnya berkas berita acara klarifikasi saksi dan bukti klinis yang lengkap serta valid.	
	b. Melaksanakan analisis akar masalah (RCA)	Menemukan faktor kontribusi sistem (beban kerja, alat, SPO) di balik pelanggaran perilaku individu.	Kasus pelanggaran berkategori sedang hingga berat (Kelompok II & III).	Manajemen Risiko & Analisis Sistem	Dokumen analisis akar masalah diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari kerja pasca-sidang.	Diperolehnya akar masalah sejati sebagai dasar perbaikan sistem pelayanan.	
	c. Menyusun surat rekomendasi formal sanksi profesi atau rehabilitasi	Memberikan keputusan legal-profesional kepada manajemen rumah sakit terkait kelayakan praktik klinis staf.	Hak klinis staf terlapor di dalam organisasi rumah sakit.	Rekomendasi Keputusan Klinis	Surat rekomendasi resmi diserahkan ke Direktur maksimal 7 hari setelah putusan sidang diambil.	Terbitnya Surat Keputusan Direktur yang berkekuatan hukum tetap (Sanksi / Rehabilitasi nama baik).	
5	Monitoring Kepatuhan Etika & Disiplin						
	a. Pemantauan harian terhadap kedisiplinan jam dinas dan atribut identitas	Menegakkan kerapian, profesionalisme penampilan, dan ketepatan waktu pelayanan Tenaga Kesehatan Lain.	Penggunaan seragam, Kartu Tanda Pengenal (ID Card), dan presensi kehadiran staf di unit kerja.	Monitoring Lapangan & Kepatuhan Aturan	Angka kepatuhan atribut dan jam dinas staf mencapai $\geq 95\%$.	Menurunnya angka pelanggaran administratif harian staf di seluruh unit pelayanan.	
	b. Mengembangkan dan mengevaluasi indikator perilaku profesional (EKPB)	Mengintegrasikan aspek perilaku ke dalam rapor performa	Lembar penilaian komponen perilaku	Evaluasi Dokumen &	Penilaian indikator perilaku dirangkul setiap 6 bulan sekali.	100% staf memiliki data capaian indikator perilaku yang	

		klinis berkala staf sebagai syarat rekredensial.	profesional seluruh staf KTKL.	Kinerja Berkelanjutan		terdokumentasi dalam berkas EKPb.	
	c. Melakukan kunjungan berkala (audit keliling/ <i>round audit</i>) ke unit pelayanan	Menilai secara langsung dinamika atmosfer kerja dan mendeteksi potensi pelanggaran etik secara dini.	Lingkungan operasional Instalasi Farmasi, Lab, Radiologi, Gizi, Rekam Medis, dan Fisioterapi.	Observasi Lapangan	Pelaksanaan audit keliling etik minimal 1 kali setiap triwulan.	Tersedianya laporan triwulanan situasi kepatuhan etik di unit pelayanan untuk Ketua Komite.	
6	Komunikasi Efektif						
	a. Mengadakan pelatihan/penyegaran tata cara komunikasi efektif edukasi pasien	Menjamin pasien memahami instruksi persiapan pra-tindakan kritis (puasa, pencahar, posisi tubuh terapi) agar tindakan akurat dan aman.	Seluruh staf Radiografer, ATLM, Gizi, dan Fisioterapis.	Pendidikan & Pengembangan	Terlaksananya pelatihan internal minimal 1 kali dalam setahun.	Angka kegagalan tindakan akibat salah persiapan pasien (<i>wrong preparation</i>) turun hingga 0%.	
	b. Membahas kemampuan staf Farmasi dalam melakukan PIO dan konseling	Memastikan pasien/keluarga paham aturan pakai obat dan merasa terlayani dengan ramah serta empatik.	Staf Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) di loket penyerahan obat.	Pembinaan Praktik Pelayanan	Indeks kepuasan pasien terhadap pelayanan informasi obat mencapai $\geq 85\%$.	Penurunan angka keluhan (<i>complaint</i>) pasien terkait komunikasi petugas Farmasi di jam sibuk.	
	c. Memfasilitasi mediasi komunikasi interprofesi klinis	Menghilangkan hambatan komunikasi koordinasi penyerahan hasil kritis, berkas rekam medis, atau instruksi terapi fisik.	Alur koordinasi lintas profesi (KTKL dengan Medis/Keperawatan).	Mediasi & Sinkronisasi Komunikasi	Penyelesaian salah paham koordinasi dilakukan secara langsung di hari yang sama.	Terwujudnya kolaborasi interprofesi yang solid dan nihil konflik operasional di lapangan.	
7	Pembuatan Kebijakan						

	a. Menyusun dan memperbarui buku panduan perilaku profesional (<i>Code of Conduct</i>)	Menyelaraskan tata aturan internal dengan UU Kesehatan No. 17/2023 dan instrumen STARKES terbaru.	Draf naskah panduan perilaku profesional KTKL RS Prima Husada Sukorejo.	Kebijakan & Regulasi Profesi	Dokumen selesai direvisi dan diselaraskan pada Triwulan II 2026.	Buku panduan dicetak, dibagikan, atau diunggah ke sistem informasi internal untuk diakses seluruh staf.	
	b. Merumuskan draf Kebijakan Direktur dan SPO alur persidangan etik	Memberikan kepastian alur penanganan laporan yang sah, rahasia, dan akuntabel dari hulu ke hilir.	SPO Pelaporan Kasus, Investigasi Kasus, dan Tata Cara Sidang Etik KTKL.	Kebijakan & Regulasi Profesi	Tersedianya 3 draf SPO tata laksana penanganan kasus yang baku pada tahun 2026.	Seluruh SPO disahkan oleh Direktur Rumah Sakit dan siap digunakan sebagai acuan legal operasional komite.	
	c. Evaluasi dan revisi berkala terhadap aturan internal staf (<i>Bylaws</i>)	Memastikan aturan disiplin korporat klinis rumah sakit tetap responsif terhadap dinamika hukum tata kelola tenaga kesehatan.	Dokumen tata hubungan kerja dan disiplin profesi Tenaga Kesehatan Lain.	Kebijakan & Regulasi Profesi	Peninjauan ulang (<i>review</i>) dokumen dilaksanakan minimal 1 kali dalam 3 tahun.	Tersusunnya draf rekomendasi amandemen Aturan Internal Staf Non-Medis yang disetujui Komite Medik dan Direksi.	

3.4 CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Tabel 3.4.1 Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
A. Sub Komite Kredensial							
1	Pelaksanaan kredensial perawat baru						
	a. Mengumpulkan dan memverifikasi dokumen STR, Ijazah, Sertifikat, Pelatihan, [engalaman kerja, evaluasi kinerja]	- Perawat menyerahkan semua dokumen persyaratan kepada Sub Komite Kredensial. - Petugas melakukan verifikasi keaslian, masa	- Verifikasi dokumen administratif - Verifikasi keaslian (online melalui	Form checklist kredensial	Saat penerimaan staf baru tenaga kesehatan lain atau minimal 1 minggu sebelum penempatan bekerja	- Form verifikasi dokumen - Copy dokumen yang sudah dilegalisir	

		berlaku, kesesuaian jabatan fungsional. Dilakukan cross-check dengan database SDM, diklat, dan unit terkait	KTKI/MTKI bila perlu)			Berita acara verifikasi	
	b. Wawancara/ assesmen kompetensi awal	- Tim kredensial melakukan wawancara terstruktur terkait pengalaman, sikap, dan kesiapan tugas. - Dilakukan assesmen kompetensi dasar (pengetahuan & keterampilan spesifik unit)	- Wawancara terstruktur - Uji kompetensi	- Form assesmen - Checksheetskill	Hari pertama proses kredensial atau sesuai penjadwalan Sub Komite	- Form hasil wawancara - Nilai ujian kompetensi	
	c. Penilaian Kompetensi Klinis Berbasis Unit	- Unit melakukan orientasi awal (unit orientation). - Kepala ruangan menilai kemampuan tindakan klinis staf baru tenaga kesehatan lainnya. - Menggunakan logbook kompetensi unit	- Observasi langsung (direct observation) - Coaching dan mentoring - Penilaian kompetensi berbasis bukti	Logbook kompetensi	1–4 minggu setelah orientasi unit	- Logbook terisi lengkap - Form penilaian kompetensi unit	
	d. Menyusun Rekomendasi Kelayakan Kredensial	- Seluruh hasil assesmen dirapatkan oleh Sub Komite. - Rekomendasi diberikan kepada Direktur terkait kelayakan perawat bekerja.	Rapat komite kredensial	Berkas assesmen	Setelah seluruh assesmen selesai	Surat rekomendasi	
2	Penetapan Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)						

	a. Penyusunan daftar kewenangan klinis berdasarkan kompetensi & area praktik	• Staf mengajukan kewenangan klinis sesuai kompetensi. • Sub Komite menilai kesesuaian kompetensi dengan kewenangan yang dimohon. • Menyelaraskan dengan regulasi Permenkes & SOP rumah sakit	• Review dokumen • Benchmarking kewenangan klinis	• Form permohonan kewenangan klinis • Daftar kewenangan klinis (privilege list)	Dilakukan sebelum staf mulai praktik mandiri di unit	Daftar privilege yang ditandatangani	
	b. Melaksanakan Kredensial	• Melakukan kredensial sesuai prosedur standar (administratif & kompetensi). • Hasil kredensial diserahkan ke Direktur	• Penilaian portofolio • Observasi keterampilan klinis	• Form kredensial	1× setiap staf baru atau saat re-kredensial	Berkas kredensial	
	c. Memberikan rekomendasi kepada direktur untuk penerbitan SK kewenangan klinis	• Sub Komite mengirim rekomendasi melalui tata naskah dinas. • Direktur meninjau dan menetapkan SK Kewenangan Klinis	Rapat Sub Komite	Surat rekomendasi	Maksimal 1 minggu setelah kredensial selesai	• Surat rekomendasi • SK Direktur (setelah persetujuan)	
	d. Sosialisasi kewenangan klinis ke unit kerja	• Mengirimkan daftar kewenangan perawat ke setiap unit. • Kepala ruangan menyesuaikan penugasan berdasarkan kewenangan	• Sosialisasi langsung • Pengumuman tertulis	• SK kewenangan • Daftar kewenangan klinis	Setelah SK diterbitkan	• Daftar hadir sosialisasi • Dokumentasi hasil sosialisasi	
3	Re-Kredensial/ perpanjangan kewenangan klinis						

	a. Mengevaluasi logbook/ realisasi tindakan	- Menelaah logbook tindakan staf selama masa berlaku kewenangan. - Mengecek kesesuaian dengan SOP & standar unit.	- Review dokumen - Audit tindakan	Logbook	Periode akhir masa kewenangan	- Form evaluasi logbook - Rekap tindakan	
	b. Review pelatihan/pendidikan lanjutan	- Memeriksa bukti pelatihan wajib & lanjutan (BHD, PPI, dll). - Memastikan pemenuhan jam pelatihan minimal	- Review sertifikat - Verifikasi ke Diklat	Sertifikat pelatihan	Tahunan	Daftar pelatihan	
	c. Menilai catatan insiden keselamatan pasien / aduan pasien	- Mengkaji insiden, near miss, atau temuan mutu yang melibatkan perawat. - Menilai apakah kompetensi masih sesuai.	- RCA (Root Cause Analysis) bila diperlukan - Review insiden	Laporan insiden	Setiap ada insiden atau saat re-kredensial	- Laporan analisis insiden - Tindak lanjut kompetensi	
	d. Merekomendasikan perpanjangan, pembatasan, atau pencabutan kewenangan	- Rapat Sub Komite menilai hasil seluruh evaluasi. - Mendeskripsikan usulan perpanjangan atau perubahan kewenangan	Rapat kredensial	- Notulen - Surat rekomendasi	Menjelang masa berlaku kewenangan berakhir	- Surat rekomendasi - SK baru (setelah disetujui Direktur)	
4	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kewenangan Klinis						
	a. Audit kepatuhan kewenangan klinis di unit	- Audit apakah perawat melakukan tindakan sesuai kewenangan. - Pemeriksaan melalui observasi & dokumentasi keperawatan.	- Audit klinis - Audit kepatuhan	- Form audit - Daftar kewenangan	Triwulanan / semesteran	- Laporan audit - Tindak lanjut monitoring	

	b. Supervisi penerapan SOP klinis sesuai kompetensi	- Kepala ruangan melakukan supervisi harian/mingguan. - Memberikan feedback kepada perawat	- Supervisi langsung - Coaching on the spot	- Form supervisi - Daftar SOP	Rutin setiap minggu / sesuai kebutuhan	Lembar supervisi	
	c. Pembinaan jika ditemukan pelanggaran kewenangan	- Mengadakan pembinaan langsung atau konseling. - Menyusun rencana perbaikan kompetensi.	- Konseling - Coaching dan mentoring	Catatan evaluasi	Setiap ada temuan pelanggaran	- Berita acara pembinaan - Rencana tindak lanjut	
	d. Merekomendasikan pelatihan tambahan pada gap kompetensi	- Mengidentifikasi pelatihan yang diperlukan staf. - Mengajukan ke bagian Diklat untuk penjadwalan pelatihan	Analisis kebutuhan pelatihan (TNA)	- Form TNA - Jadwal pelatihan	Tahunan atau sesuai kebutuhan	- Form TNA - Sertifikat pelatihan	

B. Sub Komite Mutu Profesi

1	Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Klinis KTKL						
	a. Menyusun instrumen dan kriteria audit klinis khusus untuk masing-masing rumpun profesi	Menyediakan parameter ukur yang valid, objektif, dan baku untuk menilai mutu pelayanan spesifik multi-profesi.	Dokumen mutu internal Komite KTKL RS Prima Husada Sukorejo	Kebijakan & Regulasi Profesi	Tersedianya 6 dokumen instrumen audit spesifik (1 per rumpun profesi: Farmasi, Lab, Radiologi, Gizi, Rekam Medis, dan Fisioterapi) pada Triwulan I 2026.	Dokumen instrumen audit klinis disahkan oleh Ketua Komite KTKL dan disetujui Manajemen Rumah Sakit.	
	b. Melaksanakan Audit Mutu Kefarmasian secara berkala	Mengidentifikasi hambatan alur peracikan guna memangkas durasi penyiapan obat pada jam sibuk.	Staf Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) di	Telaah Operasional & Kepatuhan SPO	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit di semua sif pelayanan.	$\geq 90\%$ sampel resep obat racikan yang diaudit memenuhi	

			Instalasi Farmasi			standar waktu tunggu yang ditetapkan.	
	c. Melaksanakan Audit Tata Kelola Rekam Medis secara periodik	Memastikan kelancaran sirkulasi berkas, ketepatan proses pengambilan kembali berkas, dan mencegah hilangnya berkas.	Staf Perekam Medis dan Informasi Kesehatan di Unit Rekam Medis	Evaluasi Dokumen & Efisiensi Alur	Waktu distribusi berkas rekam medis ke poliklinik ≤ 30 menit sebelum jam praktik dokter dimulai.	$\geq 95\%$ berkas rekam medis rawat jalan terdokumentasi dan terdistribusi secara lengkap serta tepat waktu.	
	d. Melaksanakan Audit Mutu Pelayanan Fisioterapi	Memastikan ketepatan waktu pelayanan terapi fisik dan efisiensi penjadwalan guna meminimalkan antrean pasien.	Staf Fisioterapis di Unit Fisioterapi / Rehabilitasi Medik	Evaluasi Alur Pelayanan & Waktu Respons	Waktu tunggu tindakan ≤ 15 menit sejak pasien mendaftar di loket unit Fisioterapi.	$\geq 90\%$ pasien mendapatkan pelayanan terapi fisik tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.	
	e. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap SPO tindakan teknis diagnostik	Meminimalkan risiko kesalahan klinis pada proses pra-analitik dan paparan tindakan radiasi.	Staf Radiografer (Radiologi) dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Laboratorium)	Observasi Klinis & Pengawasan Lapangan	Angka kepatuhan identifikasi pasien (SKP 1) dan akurasi teknis mencapai 100%.	Nol insiden (<i>zero accident</i>) salah identifikasi sampel laboratorium dan salah posisi paparan radiasi rontgen.	
	f. Menganalisis data hasil audit dan menyusun Rencana Tindakan Perbaikan (<i>Corrective Action Plan</i>)	Merumuskan solusi perbaikan sistem pelayanan dan memberikan rekomendasi kebijakan bagi manajemen.	Data hasil temuan audit lapangan dan manajemen instalasi terkait	Administratif & Rekomendasi Klinis	Penyusunan analisis data dan draf rekomendasi perbaikan diselesaikan maksimal 14 hari pasca-audit.	Dokumen laporan tindakan perbaikan ditandatangani oleh Kepala Instalasi terkait dan diserahkan kepada Direktur.	
2	Penyelenggaraan Forum Ilmiah dan Pembinaan Mutu (CPD)						

a. Melakukan pemetaan kesenjangan (<i>GAP</i>) kompetensi teknis klinis staf KTKL	- Membagikan form asesmen mandiri kompetensi. - Memeriksa kesesuaian antara sertifikat keahlian yang dimiliki dengan beban layanan riil.	- Survei/Kuesioner. - Evaluasi berkas portofolio.	- Aplikasi survei internal/Form cetak. - Berkas kepegawaian	Awal Tahun (Bulan Februari 2026).	- Dokumen Matriks <i>GAP</i> Kompetensi Staf KTKL. - Rekomendasi kebutuhan diklat.	
b. Memfasilitasi dan menjadwalkan kegiatan ilmiah internal (<i>Case Report, Journal Reading</i>).	- Menentukan jadwal pembicara per rumpun profesi. - Memfasilitasi penyediaan ruang forum ilmiah atau media daring. - Menerbitkan sertifikat internal bagi peserta.	- Presentasi klinis. - Diskusi interaktif interprofesi.	- Laptop, LCD proyektor / Aplikasi Zoom. - Materi/Artikel ilmiah.	Minimal 1 kali setiap triwulan (4 kali/tahun).	- Undangan & Materi Presentasi. - Daftar Hadir Peserta & Dokumentasi Foto.	
c. Menyelenggarakan Diskusi Refleksi Kasus (DRK) secara periodik.	- Memilih satu kasus riil di penunjang medis yang sulit/mengalami insiden. - Membahas kasus bersama kelompok profesi sejenis secara mendalam. - Menarik pembelajaran klinis.	- Refleksi kelompok. - Telaah kasus (<i>Peer review</i>).	- Rekam medis kasus terkait (disamarkan) - Lembar komitmen perbaikan klinis.	Minimal 2 kali dalam setahun.	- Berita Acara Pelaksanaan DRK. - Daftar Hadir & Rekomendasi Solusi Kasus.	
d. Membantu koordinasi diklat internal terakreditasi Kemenkes via portal resmi.	Berkoordinasi dengan Bagian Diklat RS untuk mendaftarkan materi diklat ke LMS.	- Sinkronisasi sistem digital. - Pendampingan administratif.	Portal Plataran Sehat Kemenkes.	Berjalan berkala sepanjang tahun 2026	Tanda bukti verifikasi pelatihan di LMS.	

		- Membimbing staf mengaktifkan akun kementerian. - Memantau input capaian SKP staf.		Akun SatuSehat SDMK staf.		Laporan rekapitulasi nilai SKP tahunan staf.	
3	Pembinaan Praktik Profesional dan Kepatuhan SOP						
	a. Sosialisasi dan Internalisasi SPO Klinis Terintegrasi.	- Mengumpulkan perwakilan staf penunjang. - Membedah isi SPO pelayanan terbaru. - Melakukan simulasi penerapan alur pelayanan baru di unit kerja.	- Pemaparan /Presentasi. - Bedah dokumen SPO.	- Berkas fisik SPO resmi RS. - Media sosialisasi (infografis/slide).	Setiap ada SPO baru atau minimal 1 kali per triwulan.	- Daftar hadir sosialisasi staf. - Lembar komitmen kepatuhan pelaksanaan SPO.	
	b. Pelaksanaan Supervisi Klinis Berkala dan Audit Kepatuhan Lapangan.	- Tim sub komite mutu turun ke lapangan (Farmasi, RM, Gizi, dll). - Memeriksa kesesuaian operasional di lapangan dengan panduan SPO tertulis.	- Ronde klinis (<i>Clinical Round</i>). - Inspeksi mendadak (Sidak).	- Formulir penilaian supervisi lapangan. - Buku log pengawasan mutu.	Dilakukan mingguan secara acak.	- Buku catatan supervisi klinis harian. - Laporan triwulanan kepatuhan lapangan.	
	c. Evaluasi Praktik Profesional Berkelanjutan (OPPE).	- Mengumpulkan data indikator kinerja mutu individu staf. - Mengisi lembar penilaian instrumen OPPE berdasarkan rekam jejak kerja.	- Evaluasi data sekunder. - Penilaian kinerja portfolio.	- Lembar instrumen OPPE KTKL. - Database logbook tindakan harian.	Setiap 6 bulan sekali (Per Semester).	- Rapor penilaian dokumen OPPE tiap staf. - Rekomendasi kelayakan kelanjutan kewenangan klinis.	

		Menganalisis nilai akhir performa staf.					
	d. Tindak Lanjut Pembinaan dan Konseling Praktik Klinis.	- Memanggil staf yang memiliki nilai audit/OPPE di bawah standar. - Mengidentifikasi kendala teknis yang dialami staf. - Memberikan pembekalan ulang atau pendampingan khusus (<i>proctoring</i>).	- Wawancara tatap muka pribadi. - Pendampingan praktik klinis langsung.	- Lembar komitmen perbaikan kinerja. - Dokumen panduan supervisi.	Maksimal 7 hari setelah hasil evaluasi OPPE/Audit keluar.	- Berita acara konseling praktik. - Logbook absensi pendampingan khusus staf.	
4	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien & Budaya Keselamatan						
	a. Monitoring berkala terhadap kepatuhan pelaksanaan identifikasi pasien (SKP 1).	- Mengamati kepatuhan petugas saat meminta pasien menyebutkan nama dan tgl lahir. - Mencocokkan gelang identitas/barcode resep/sampel secara langsung.	- Sosialisasi - Audit kepatuhan SKP	Formulir audit kepatuhan identifikasi pasien.	Setiap bulan	- Data persentase kepatuhan identifikasi pasien. - Laporan indikator mutu nasional (IMN) unit.	
	b. Memantau kepatuhan penerapan komunikasi efektif metode <i>Read-back & Confirm</i> (SKP 2).	- Memeriksa stempel/catatan <i>TBAK</i> pada berkas rekam medis. - Mengamati kepatuhan konfirmasi lisan saat pelaporan nilai kritis via telepon.	- Audit rekam medis. - Observasi simulasi pelaporan lisan.	- Berkas rekam medis pasien. - Checklist kepatuhan pelaporan nilai kritis.	Setiap bulan	- Lembar audit rekam medis komponen SKP - Rekap logbook ketepatan waktu lapor nilai kritis.	

	c. Mengidentifikasi, mencatat, dan mengkaji setiap kejadian insiden keselamatan pasien (KNC, KTD, KPC).	- Menerima formulir laporan insiden dari unit penunjang. - Melakukan klasifikasi jenis insiden berdasarkan <i>grading</i> risiko. - Menggelar pertemuan investigasi guna mencari perbaikan sistem.	- RCA - Investigasi sederhana.	- Formulir Laporan Insiden internal RS. - Matriks grading risiko Kemenkes.	Maksimal 2x24 jam sejak insiden terjadi di unit kerja	- Dokumen Berkas Laporan Insiden Keselamatan. - Lembar Rekomendasi Perbaikan Sistem Mutu KTKL.	
C. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi Keperawatan							
1	Pembinaan Etika Profesional dan Perilaku Klinis						
	a. Menyusun dan memperbarui panduan perilaku profesional.	1. Mengumpulkan materi draf referensi dari asosiasi profesi nakes penunjang. 2. Mengadakan rapat penyelarasan isi materi dengan aturan internal rumah sakit.	- Diskusi panel. - Telaah regulasi fungsional.	- Referensi aturan nakes. - Komputer / Software pengetikan.	Triwulan I (Bulan Maret 2026).	- Undangan, Daftar Hadir, & Notulen Rapat. - Draf dokumen <i>Code of Conduct</i> KTKL.	
	b. Melaksanakan sosialisasi berkala mengenai kode etik profesi & orientasi budaya pelayanan prima.	1. Mengumpulkan perwakilan staf di aula / ruang diklat. 2. Menyampaikan materi etika asuhan serta pentingnya empati pelayanan untuk menekan komplain.	-Pemaparan /Presentasi. - Ceramah tanya jawab.	- Slide materi presentasi. - Laptop & LCD Proyektor.	Dua kali dalam setahun (Per Semester).	- Undangan & Daftar Hadir Sosialisasi. - Dokumentasi foto kegiatan.	
	c. Menyelenggarakan forum edukasi preventif mengenai	1. Mengundang pakar hukum kesehatan / narasumber internal legal rumah sakit.	- Seminar mini. - Bedah kasus hukum	- Studi kasus hukum kesehatan.	Satu kali dalam setahun (Triwulan II).	- Sertifikat pembicara/peserta.	

	batasan hukum dan disiplin profesi.	2. Membahas studi kasus riil terkait risiko malpraktik di unit penunjang.		- Modul edukasi disiplin.		- Berkas materi edukasi hukum.	
	d. Memberikan layanan konseling dan pembinaan dini bagi staf yang mengalami penurunan perilaku.	1. Menerima usulan nama staf dari Kepala Instalasi penunjang. 2. Memanggil staf secara personal untuk tatap muka. 3. Menggali faktor kendala perilaku dan memberikan arahan solusi.	- Wawancara mendalam. - <i>Personal coaching</i> .	- Formulir konseling karyawan. - Ruang konsultasi privat.	Insidental (Maksimal 7 hari setelah laporan unit masuk).	- Berita acara konseling. - Lembar rekomendasi perbaikan perilaku.	
2	Pencegahan Pelanggaran Etika dan Disiplin						
	a. Melaksanakan sosialisasi berkala mengenai Kode Etik Profesi rumpun nakes	Menyegarkan kembali komitmen staf terhadap sumpah profesi dan batasan etika masing-masing.	Kelompok profesi (Apoteker/TTK, Radiografer, ATLM, Dietisien, Perekam Medis, dan Fisioterapis).	Checklist audit	1 tahun sekali	- Absensi kehadiran per rumpun profesi. - Notulen hasil penyegaran etika.	
	b. Forum edukasi preventif batasan kewenangan klinis & aspek hukum	Mencegah staf melakukan tindakan di luar mandat dokumen Rincian Kewenangan Klinis (RKK).	Seluruh staf Tenaga Kesehatan Lain yang memegang Surat Penugasan Klinis (SPK).	Modul edukasi	1 tahun sekali	- Lembar pakta integritas kepatuhan RKK. - Dokumen daftar tilik batas wewenang unit	

	c. Memberikan layanan konseling preventif ketidakharmonisan antar-pribadi	Mencegah konflik horizontal antarstaf meluas hingga mengganggu kelancaran operasional pelayanan pasien.	Hubungan kerja antarstaf internal unit maupun lintas profesi.	Lembar komitmen perdamaian/kerja sama.	Segera setelah ditemukan indikasi gesekan di unit.	- Berita acara mediasi internal. - Catatan monitoring iklim kerja pasca-mediasi.	
3	Penanganan Kasus Pelanggaran Etika & Disiplin						
	a. Menerima, mencatat, dan menelaah setiap laporan aduan atau komplain perilaku staf.	1. Mengambil berkas aduan dari kotak saran, humas, atau nota dinas internal. 2. Mencatatnya ke dalam buku register penanganan kasus komite.	- Validasi laporan. - Penyaringan administratif.	- Buku registrasi pengaduan. - Berkas surat laporan pengaduan.	Maksimal 3x24 jam sejak aduan diterima komite.	- Lembar logbook laporan pengaduan. - Lembar disposisi Ketua Komite KTKL.	
	b. Menentukan kelayakan kasus dan klasifikasi pelanggaran dengan Matriks Skor (1-100).	1. Menggelar rapat internal inti sub komite etik. 2. Mencocokkan bukti awal dengan parameter matriks skor. 3. Menetapkan bobot kasus (Ringan/Sedang/Berat)	- Rapat penilaian objektif. - Scoring kasus.	- Matriks Kategorisasi Pelanggaran (1-100).	Maksimal 5 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.	- Lembar formulir hasil penilaian scoring kasus. - Notulen rapat penetapan status kasus.	
	c. Menggelar Sidang Ad-Hoc penegakan disiplin profesi yang objektif.	1. Mengundang pengurus komite, nakes terlapor, dan Mitra Bestari rumpun terkait. 2. Membuka persidangan	- Sidang klinis formal. - <i>Peer examination</i> .	- Tata tertib persidangan. - Sarana ruang sidang khusus.	Sesuai jadwal yang disepakati (Maksimal 14 hari pasca-scoring).	- Berita Acara Persidangan Etik. - Daftar hadir seluruh peserta sidang.	

		tertutup untuk mendengar keterangan secara seimbang.					
4	Investigasi & Rekomendasi Sanksi / Rehabilitasi						
	a. Melakukan pengumpulan bukti klinis, telaah dokumen, dan memanggil saksi.	Menyusun tim investigasi & melakukan investigasi	- Investigasi dokumen. - Klarifikasi saksi.	- Berkas rekam medis/logbook. - Form berita acara klarifikasi.	Sebelum pelaksanaan sidang Ad-Hoc dilakukan.	- Berkas fisik alat bukti pendukung. - Lembar Surat Pernyataan Saksi.	
	b. Melaksanakan analisis akar masalah (<i>Root Cause Analysis</i> / RCA).	Melakukan diagram sebab-akibat	Metode RCA (<i>Root Cause Analysis</i>).	- Lembar kerja diagram Fishbone / 5-Whys.	Maksimal 14 hari kerja pasca-sidang Ad-Hoc.	- Dokumen Laporan RCA Kasus. - Lembar kesimpulan faktor penyebab insiden.	
	c. Menyusun surat rekomendasi formal kepada Direktur (Sanksi / Rehabilitasi).	Menetapkan sanksi bersama direktur/SDM	- Formulasi legal komite. - Korespondensi kedinasan.	- Lembar draf rekomendasi keputusan. - Buku ekspedisi surat keluar.	Maksimal 7 hari kerja setelah dokumen RCA selesai.	- Surat Rekomendasi Resmi Komite KTKL ke Direktur. - Tanda terima surat oleh sekretariat Direksi.	
5	Monitoring Kepatuhan Etika & Disiplin						
	a. Melakukan pemantauan harian terhadap kedisiplinan jam	1. Melakukan pemeriksaan acak jadwal presensi dan kerapian seragam staf di unit kerja.	- Inspeksi langsung. - Audit kepatuhan aturan.	- Checklist kelengkapan atribut seragam.	Dilakukan mingguan secara acak (sidak).	- Lembar hasil sidak kerapian/kedisiplinan	

	dinas dan atribut identitas (<i>ID Card</i>).	2. Memberikan teguran langsung di tempat jika ditemukan pelanggaran atribut.		- Data presensi kehadiran unit.		- Laporan rekap bulanan kepatuhan atribut.	
	b. Mengembangkan dan mengevaluasi indikator perilaku profesional staf (OPPE).	1. Menjaring data keluhan dari Kepala Instalasi terkait sikap staf. 2. Memasukkan nilai komponen perilaku ke dalam lembar gabungan evaluasi berkala.	- Evaluasi dokumen sekunder. - Penilaian performa perilaku.	- Formulir instrumen OPPE (Komponen Perilaku).	Setiap 6 bulan sekali (Per Semester).	- Berkas rapor OPPE komponen perilaku tiap staf. - Rekapitulasi nilai kepatuhan perilaku staf.	
	c. Melakukan kunjungan berkala (<i>round audit</i>) ke unit-unit penunjang medis	1. Anggota sub komite mendatangi area kerja Farmasi, Lab, Rad, Gizi, dan RM. 2. Berdialog dengan petugas mengenai kondisi iklim kerja dan kendala layanan.	- Ronde etika lapangan	Lembar catatan pemantauan ronde.	Setiap triwulan sekali.	- Dokumen Laporan Kunjungan Triwulanan. - Catatan rekomendasi peningkatan suasana kerja.	
6	Komunikasi Efektif						
	a. Mengadakan pelatihan/penyegaran tata cara komunikasi efektif edukasi pasien.	1. Melakukan <i>role-play</i> (simulasi) cara nakes memberikan instruksi persiapan tindakan kepada pasien. 2. Mengevaluasi kejelasan bahasa instruksi petugas.	- Pelatihan aplikatif (<i>Role-play</i>). - Simulasi pelayanan.	- Modul komunikasi efektif komunikasi klinis. - Lembar skenario simulasi.	Satu kali dalam setahun (Triwulan III).	- Daftar hadir & dokumentasi foto pelatihan. - Lembar hasil evaluasi praktik <i>role-play</i> .	

	b. Membina kemampuan staf Farmasi dalam melakukan PIO dan konseling obat.	1. Mengamati tata cara Apoteker/TTK menyerahkan obat di loket. 2. Memberikan contoh teknik komunikasi empatik di jam sibuk pelayanan.	Pendampingan lapangan (<i>On-the-job training</i>).	Panduan Pemberian Informasi Obat (PIO).	Minimal 1 kali setiap semester.	- Formulir penilaian kualitas konseling obat. - Rekap logbook pemberian informasi obat.	
	c. Memfasilitasi mediasi komunikasi interprofesi klinis.	1. Mengumpulkan perwakilan komite/staf lintas penunjang yang mengalami sumbatan informasi. 2. Menyepakati keseragaman pemahaman istilah klinis.	- Diskusi penyelarasan alur. - Pertemuan rekonsiliasi.	Alur komunikasi antar-unit (SPO koordinasi).	Jika terjadi kendala komunikasi koordinasi di lapangan.	- Notulen kesepakatan tata cara komunikasi baru. - Daftar hadir koordinasi interprofesi.	
7	Pembuatan Kebijakan						
	a. Menyusun dan memperbarui buku panduan perilaku profesional (<i>Code of Conduct</i>) terbaru.	1. Mengetik draf penyelarasan aturan komite dengan UU Kesehatan No. 17/2023. 2. Mengajukan draf cetak ke bagian hukum rumah sakit untuk dikoreksi legalitasnya.	- Penyusunan regulasi internal. - <i>Legal drafting</i> .	- Draf naskah perubahan panduan. - Undang-Undang Kesehatan terbaru.	Triwulan II (Bulan Mei - Juni 2026).	- Dokumen final <i>Code of Conduct</i> yang direvisi. - Tanda terima penyerahan draf ke Bagian Hukum.	
	b. Merumuskan draf Kebijakan Direktur dan SPO alur persidangan etik.	1. Membuat bagan alur proses pelaporan dari masuk hingga putusan sanksi. 2. Melakukan pengajuan	- Standardisasi dokumen kebijakan.	- Template SPO resmi rumah sakit. - Bagan alur	Triwulan III (Bulan Agustus 2026).	- Berkas draf Surat Keputusan & SPO Sidang Etik. - Tanda bukti	

		terkait SPO alur persidangan etik.		skema penanganan kasus		koordinasi penyusunan regulasi.	
	c. Melakukan evaluasi dan revisi berkala terhadap aturan internal staf	1. Memeriksa relevansi poin hak-kewajiban nakes penunjang dengan standar akreditasi (STARKES). 2. Merevisi pasal tata tertib yang sudah kedaluwarsa.	- Peninjauan ulang regulasi korporat. - Rapat amandemen pasal.	Dokumen induk aturan tata kelola staf non-medis.	Minimal 1 kali dalam 3 tahun (Siklus peninjauan 2026).	- Berkas usulan perubahan (Amandemen) pasal <i>Bylaws</i> . - Notulen persetujuan bersama pengurus Komite KTKL.	

3.5 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tabel 3.5.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
A. Sub Komite Kredensial																		
1	Pelaksanaan kredensial perawat baru																	
	a. Mengumpulkan dan memverifikasi dokumen STR, Ijazah, Sertifikat, Pelatihan, [engalaman kerja, evaluasi kinerja	Dokumen kewenangan klinis tersedia & diperbarui 1x/tahun.		√												RS	Sub Kredensial	RS
	b. Wawancara/ assesmen kompetensi awal	Kredensial dilaksanakan pada seluruh perawat aktif		√												RS	Sub Kredensial	RS

	c. Penilaian Kompetensi Klinis Berbasis Unit	SK terbit ≤ 14 hari setelah kredensial				√										RS	Sub Kredensial	RS
	d. Menyusun Rekomendasi Kelayakan Kredensial	Sosialisasi dilakukan 100% ke seluruh unit.				√										RS	Sub Kredensial	RS
2	Penetapan Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)																	
	a. Penyusunan daftar kewenangan klinis berdasarkan kompetensi & area praktik	Dokumen kewenangan klinis tersedia & diperbarui 1x/tahun.		√												RS	Sub Kredensial	RS
	b. Melaksanakan Kredensial	Kredensial dilaksanakan pada seluruh perawat aktif		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Kredensial	RS
	c. Memberikan rekomendasi kepada direktur untuk penerbitan SK kewenangan klinis	SK terbit ≤ 14 hari setelah kredensial		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Kredensial	RS
	d. Sosialisasi kewenangan klinis ke unit kerja	Sosialisasi dilakukan 100% ke seluruh unit.		√												RS	Sub Kredensial	RS
3	Re-kredensial/ perpanjangan kewenangan klinis																	
	a. Mengevaluasi logbook/ realisasi tindakan	100% logbook diverifikasi setiap tenaga keperawatan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Kredensial	RS

		sebelum masa izin berakhir																
	b. Review pelatihan/pendidikan lanjutan	Semua pelatihan relevan dengan area praktik		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Kredensial	RS
	c. Menilai catatan insiden keselamatan pasien / aduan pasien	- Tidak ada insiden sentinel. - Bila ada insiden KNC/NKNC telah dilakukan RCA & pembinaan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Kredensial	RS
	d. Merekomendasikan perpanjangan, pembatasan, atau pencabutan kewenangan	Rekomendasi diberikan maksimal 30 hari setelah evaluasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Kredensial	RS
4	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan klinis	Audit dilakukan minimal 2x/tahun																
	a. Audit kepatuhan kewenangan klinis di unit	Supervisi minimal 1x/bulan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Kredensial	RS
	b. Supervisi penerapan SOP klinis sesuai kompetensi	Pembinaan diberikan maksimal 3 hari setelah temuan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Kredensial	RS

	c. Pembinaan jika ditemukan pelanggaran kewenangan	- Semua gap kompetensi memiliki rencana pelatihan. - Minimal 80% pelatihan terlaksana setiap tahun		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Kredensial	RS
	d. Merekomendasikan pelatihan tambahan pada gap kompetensi	Audit dilakukan minimal 2x/tahun		√						√						RS	Sub Kredensial	RS
B. Sub Komite Mutu Profesi																		
1	Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Klinis KTKL																	
	a. Menyusun instrumen dan kriteria audit klinis khusus untuk masing-masing rumpun profesi.	Tersedianya 5 dokumen instrumen audit spesifik (1 per rumpun profesi) pada Triwulan I 2026.		√												RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS
	b. Melaksanakan Audit Mutu Kefarmasian berkala fokus pada waktu tunggu obat racikan.	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤60 menit di semua sif pelayanan.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS
	c. Melaksanakan Audit Tata Kelola Rekam Medis fokus pada	Waktu distribusi berkas RM ke poliklinik ≤ 30 menit sebelum				√			√			√			√	RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS

	sirkulasi & distribusi berkas.	jam praktik dokter dimulai.																
	d. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap SPO tindakan teknis diagnostik (Lab & Rad).	Angka kepatuhan identifikasi pasien (SKP 1) dan akurasi teknis mencapai 100% .							√						√	RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS
	e. Melaksanakan Audit Mutu Pelayanan Fisioterapi	Waktu tunggu tindakan ≤ 15 menit sejak pasien mendaftar di loket.							√						√			
	f. Menganalisis data hasil audit, merumuskan rekomendasi, dan menyusun CAP.	Penyusunan analisis data dan draf rekomendasi CAP diselesaikan maksimal 14 hari pasca-audit.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS
2	Penyelenggaraan Forum Ilmiah dan Pembinaan Mutu (CPD)																	
	a. Melakukan pemetaan kesenjangan (GAP) kompetensi teknis klinis.	Pemetaan kompetensi seluruh staf selesai 100% pada awal tahun (Triwulan I 2026).		√												RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS
	b. Memfasilitasi dan menjadwalkan kegiatan ilmiah internal.	Terlaksananya forum ilmiah internal minimal 4 kali dalam setahun (1 kali per triwulan).			√			√			√			√		RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS

	c. Menyelenggarakan Diskusi Refleksi Kasus (DRK) secara periodik.	Pelaksanaan DRK minimal 2 kali dalam setahun (1 kali per semester).					√					√				RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS
	d. Koordinasi fasilitasi diklat internal terakreditasi Kemenkes.	≥90% staf terpantau aktif dan mengalami progres pencapaian SKP di portal resmi.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS
3	Pembinaan Praktik Profesional dan Kepatuhan SPO																	
	a. Sosialisasi dan Internalisasi Standar Prosedur Operasional (SPO) Klinis Terintegrasi.	Meningkatkan pemahaman staf terhadap pembaruan SPO pelayanan klinis penunjang							√						√	RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS
	b. Pelaksanaan Supervisi Klinis Berkala dan Audit Kepatuhan Lapangan.	Memantau secara langsung kepatuhan harian staf terhadap pelaksanaan SPO		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS
	c. Evaluasi Praktik Profesional Berkelanjutan (<i>Ongoing Professional Practice Evaluation / OPPE</i>).	Penurunan ketidaksesuaian ≥ 50% dalam 6 bulan							√						√	RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS
	d. Rekomendasi re-pelatihan	Pelaksanaan program		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS

		pendampingan (<i>proctoring</i>) diselesaikan maksimal 1 bulan sejak rekomendasi diterbitkan.																
4	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien & Budaya Keselamatan																	
	a. Melakukan monitoring berkala terhadap kepatuhan pelaksanaan identifikasi pasien (SKP 1).	Kepatuhan verifikasi identitas pasien mencapai 100% di seluruh unit penunjang tanpa toleransi deviasi.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS
	b. Memantau kepatuhan penerapan komunikasi efektif metode <i>Read-back & Confirm</i> (SKP 2).	Kepatuhan konfirmasi balik dan pencatatan nilai kritis terdokumentasi 100% di rekam medis pasien.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS
	c. Analisis insiden keselamatan (KNC, KTD, KPC, sentinel)	100% insiden keselamatan yang ditemukan wajib dilaporkan resmi dalam waktu 2x24 jam ke Komite Mutu.	Jika terjadi insiden												RS	Sub Komite Mutu Profesi	RS	
C. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi																		
1	Pembinaan Etika Profesional dan Perilaku Klinis																	

	a. Menyusun dan memperbarui panduan perilaku profesional.	Tersusunnya 1 dokumen panduan utuh yang mencakup seluruh profesi KTKL di Semester I 2026.				√										RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS
	b. Melaksanakan sosialisasi berkala kode etik profesi & budaya pelayanan prima.	Terlaksananya sosialisasi minimal 2 kali dalam setahun (per semester)						√							√	RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS
	c. Menyelenggarakan forum edukasi preventif mengenai batasan hukum & disiplin.	Terlaksananya forum edukasi hukum kesehatan 1 kali dalam setahun.					√									RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS
	d. Layanan konseling dan pembinaan dini bagi staf bermasalah.	Respons dan pelaksanaan konseling diselesaikan maksimal 7 hari setelah laporan unit masuk.	Insidental (Maksimal 7 hari setelah laporan unit masuk).												RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS	
2	Pencegahan pelanggaran etika dan disiplin																	
	a. Melaksanakan sosialisasi berkala mengenai Kode Etik Profesi rumpun nakes.	Terlaksananya pertemuan berkala per rumpun profesi 1 kali setahun.						√								RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS

	b. Forum edukasi preventif batasan kewenangan klinis & aspek hukum.	Kepatuhan praktik sesuai RKK mencapai 100% di seluruh unit kerja.								√						RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS
	c. Memberikan layanan konseling preventif ketidakharmonisan interpersonal.	Penyelesaian mediasi internal tuntas sebelum masuk ke ranah pelanggaran formal.	Segera setelah ditemukan indikasi gesekan di unit.															
3	Penanganan Kasus Pelanggaran Etika & Disiplin																	
	a. Menerima, mencatat, dan menelaah setiap laporan aduan atau komplain.	Telaah awal kelayakan laporan diselesaikan dalam waktu maksimal 3x24 jam sejak diterima.	Maksimal 3x24 jam sejak aduan diterima komite.												RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS	
	b. Mengukur derajat keparahan pelanggaran secara objektif agar sanksi yang diusulkan bersifat proporsional.	Klasifikasi kasus (Kelompok I, II, III) ditetapkan secara mufakat pada rapat internal.	Maksimal 5 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.												RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS	
	c. Menggelar Sidang Ad-Hoc penegakan disiplin profesi yang objektif.	Pelaksanaan sidang Ad-Hoc diselenggarakan sesuai regulasi rumah sakit yang berlaku.	Sesuai jadwal yang disepakati (Maksimal 14 hari pasca-scoring).												RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS	
4	Investigasi dan rekomendasi sanksi/ rehabilitasi																	

	a. Melakukan pengumpulan bukti klinis dan memanggil saksi.	Pengumpulan seluruh alat bukti diselesaikan sebelum sidang Ad-Hoc digelar.	Sebelum pelaksanaan sidang Ad-Hoc dilakukan.												RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS	
	b. Melaksanakan analisis akar masalah (<i>Root Cause Analysis</i> / RCA).	Dokumen RCA diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari kerja pasca-sidang.	Maksimal 14 hari kerja pasca-sidang Ad-Hoc.												RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS	
	c. Menyusun surat rekomendasi formal sanksi profesi atau rehabilitasi.	Surat rekomendasi resmi diserahkan ke Direktur maksimal 7 hari setelah putusan sidang diambil.	Maksimal 7 hari kerja setelah dokumen RCA selesai.												RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS	
5	Monitoring kepatuhan etika dan disiplin																	
	a. Pemantauan harian terhadap kedisiplinan jam dinas dan atribut identitas.	Angka kepatuhan atribut dan jam dinas staf mencapai ≥95%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS
	b. Mengembangkan dan mengevaluasi indikator perilaku profesional (OPPE).	Penilaian indikator perilaku dirangkum setiap 6 bulan sekali .						√							√	RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS
	c. Melakukan kunjungan berkala (<i>round audit</i>) ke unit penunjang medis.	Pelaksanaan ronde audit etik minimal 1 kali setiap triwulan .				√			√			√			√	RS	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi	RS
6	Komunikasi Efektif																	

	a.Mengadakan pelatihan/penyegaran tata cara komunikasi efektif edukasi pasien.	Terlaksananya pelatihan internal minimal 1 kali dalam setahun.							√									
	b. Membina kemampuan staf Farmasi dalam melakukan PIO dan konseling.	Indeks kepuasan pasien terhadap pelayanan informasi obat mencapai ≥85%.				√					√							
	c. Memfasilitasi mediasi komunikasi interprofesi klinis.	Penyelesaian salah paham koordinasi dilakukan secara langsung di hari yang sama.	Jika terjadi kendala komunikasi koordinasi di lapangan.															
7	Pembuatan Kebijakan																	
	a. Menyusun dan memperbarui buku panduan perilaku profesional (Code of Conduct).	Dokumen selesai direvisi dan diselaraskan pada Triwulan II 2026 .							√									
	b. Merumuskan draf Kebijakan Direktur dan SPO alur persidangan etik.	Tersedianya 3 draf SPO tata laksana penanganan kasus yang baku pada tahun 2026.									√							
	c. Evaluasi dan revisi berkala terhadap aturan internal staf (Non-Medical Staff Bylaws).	Peninjauan ulang (<i>review</i>) dokumen dilaksanakan minimal 1 kali dalam 3 tahun .	Minimal 1 kali dalam 3 tahun (Siklus peninjauan 2026).															

3.6 KEBUTUHAN ANGGARAN

Tabel 3.6.1 Kebutuhan Anggaran

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JENIS	KEBUTUHAN SATU TAHUN	HARGA SATUAN	TOTAL ANGGARAN
	Sub Komite Kredensial					
1	Pelaksanaan kredensial staf baru	Mengumpulkan dan memverifikasi dokumen (STR, Ijazah, Sertifikat pelatihan, pengalaman kerja, evaluasi kinerja)	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Wawancara/ assesmen kompetensi awal	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Penilaian kompetensi klinis berbasis unit	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Menyusun rekomendasi kelayakan kredensial	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
2	Penetapan kewenangan klinis (<i>Clinical Privilege</i>)	Menyusun daftar kewenangan klinis berdasarkan kompetensi dan area praktik	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Melaksanakan kredensial	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk penerbitan SK kewenangan klinis	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Sosialisasi kewenangan klinis ke unit kerja	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
3	Re-Kredensial/ perpanjangan kewenangan klinis	Mengevaluasi logbook / realisasi tindakan	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Review pelatihan / pendidikan lanjutan	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Menilai catatan insiden keselamatan pasien / aduan pasien	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Merekomendasikan perpanjangan, pembatasan, atau pencabutan kewenangan	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
4	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan klinis	Audit kepatuhan kewenangan klinis di unit	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Supervisi penerapan SOP klinis sesuai kompetensi	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Pembinaan jika ditemukan pelanggaran kewenangan	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Merekomendasikan pelatihan tambahan pada gap kompetensi	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
	Sub Komite Mutu Profesi					

1	Pelaksanaan Audit Mutu Pelayanan Klinis KTKL	Menyusun instrumen dan kriteria audit klinis khusus untuk masing-masing rumpun profesi (Farmasi, Fisioterapi, Laboratorium, Radiologi, Gizi, dan Rekam Medis).	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Melaksanakan Audit Mutu Kefarmasian secara berkala yang difokuskan pada analisis hambatan dan pemangkasan alur sediaan guna menurunkan waktu tunggu pelayanan obat racikan pada jam sibuk (<i>peak hours</i>).	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Melaksanakan Audit Tata Kelola Rekam Medis secara periodik dengan fokus pada kepatuhan <i>retrieval</i> berkas, kelengkapan pengisian, serta kecepatan waktu distribusi berkas rekam medis ke poliklinik rawat jalan.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Melaksanakan audit kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) tindakan teknis diagnostik di unit Laboratorium dan Radiologi.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Melaksanakan audit kepatuhan terhadap SPO tindakan teknis diagnostik di unit Laboratorium dan Radiologi, serta audit waktu tunggu di Fisioterapi.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Menganalisis data hasil audit, merumuskan rekomendasi perbaikan sistem, dan menyusun rencana tindak lanjut (<i>RTL</i>) bersama Kepala Instalasi terkait untuk diserahkan kepada Direktur.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
2	Penyelenggaraan Forum Ilmiah dan Pembinaan Mutu (CPD)	Melakukan pemetaan kesenjangan (<i>GAP</i>) kompetensi teknis klinis staf KTKL berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Memfasilitasi dan menjadwalkan kegiatan ilmiah internal seperti <i>Case Report</i> (Laporan Kasus), <i>Journal Reading</i> (Telaah Jurnal), seminar mini, atau <i>Internal Workshop</i> lintas profesi penunjang.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0

		Menyelenggarakan Diskusi Refleksi Kasus (DRK) minimal 2 kali dalam setahun untuk membahas insiden klinis, kasus sulit, atau area pelayanan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Membantu koordinasi dengan Bagian Diklat Rumah Sakit dalam memfasilitasi diklat internal yang terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan untuk mempercepat pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) staf melalui portal resmi.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
3	Pembinaan Praktik Profesional dan Kepatuhan SOP	Sosialisasi dan Internalisasi Standar Prosedur Operasional (SPO) Klinis Terintegrasi	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Pelaksanaan Supervisi Klinis Berkala dan Audit Kepatuhan Lapangan	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Evaluasi Praktik Profesional Berkelanjutan (Ongoing Professional Practice Evaluation / OPPE)	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Tindak Lanjut Pembinaan dan Konseling Praktik Klinis	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
4	Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien & Budaya Keselamatan	Melakukan monitoring berkala terhadap kepatuhan pelaksanaan identifikasi pasien (SKP 1) secara ketat sebelum pengambilan sampel darah di Laboratorium, paparan radiasi di Radiologi, atau penyerahan obat di Farmasi.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Memantau kepatuhan penerapan komunikasi efektif menggunakan metode <i>Read-back & Confirm</i> (Tulis, Baca kembali, Konfirmasi) saat pelaporan nilai kritis laboratorium oleh ATLM atau instruksi verbal obat kedaruratan oleh Apoteker.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Mengidentifikasi, mencatat, dan mengkaji setiap kejadian insiden keselamatan pasien—baik Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), maupun Kejadian Potensial	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0

		Cedera (KPC)—yang terjadi di lingkup pelayanan penunjang medis sebagai bahan evaluasi mutu profesi.				
		Melakukan monitoring berkala terhadap kepatuhan pelaksanaan identifikasi pasien (SKP 1) secara ketat sebelum pengambilan sampel darah di Laboratorium, paparan radiasi di Radiologi, atau penyerahan obat di Farmasi.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
	Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi					
1	Pembinaan Etika Profesional dan Perilaku Klinis	Menyusun dan memperbarui panduan perilaku profesional (<i>Code of Conduct</i>) yang diselaraskan dengan etika profesi masing-masing rumpun Tenaga Kesehatan Lain (Apoteker/TTK, Fisioterapis Radiografer, ATLM, Dietisien, dan Perekam Medis).	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Melaksanakan sosialisasi berkala mengenai kode etik profesi dan orientasi budaya pelayanan prima berbasis keselamatan pasien (<i>Patient-Centered Care</i>).	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Menyelenggarakan forum edukasi preventif mengenai batasan hukum dan disiplin profesi guna mencegah terjadinya malpraktik atau kelalaian teknis di unit penunjang.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Memberikan layanan konseling dan pembinaan dini bagi staf Tenaga Kesehatan Lain yang teridentifikasi mengalami penurunan kinerja perilaku atau menunjukkan tanda-tanda masalah interpersonal di lingkungan kerja.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
2	Pencegahan pelanggaran etika dan disiplin	Melaksanakan sosialisasi berkala mengenai Kode Etik Profesi masing-masing rumpun nakes lain (Apoteker/TTK, Fisioterapis, Radiografer, ATLM, Dietisien, dan Perekam Medis).	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0

		Menyelenggarakan forum edukasi preventif mengenai batasan kewenangan klinis dan aspek hukum pelayanan guna mencegah terjadinya kelalaian teknis di unit kerja.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Memberikan layanan konseling preventif dan pembinaan dini bagi staf yang menunjukkan indikasi penurunan kinerja perilaku atau ketidakharmonisan interpersonal sebelum berkembang menjadi pelanggaran formal.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
3	Penanganan kasus pelanggaran etika dan disiplin	Menerima, mencatat, dan menelaah setiap laporan aduan atau komplain dari pasien, keluarga, maupun sesama Profesional Pemberi Asuhan (PPA) terkait perilaku staf penunjang.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Menentukan kelayakan kasus dan mengklasifikasikan dugaan pelanggaran berdasarkan parameter Matriks Kategorisasi Pelanggaran dengan Nilai Skor (1–100) ke dalam tingkatan: Kelompok I (Ringan), Kelompok II (Sedang), dan Kelompok III (Berat).	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Menggelar Sidang Ad-Hoc penegakan disiplin profesi yang objektif dengan melibatkan pengurus komite dan Mitra Bestari (<i>Peer Review</i>) yang sesuai dengan profesi staf terlapor.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
4	Investigasi dan rekomendasi sanksi/rehabilitasi	Melakukan pengumpulan bukti klinis, telaah dokumen logbook tindakan, sirkulasi berkas rekam medis, atau pencatatan sediaan obat, serta memanggil saksi-saksi terkait untuk proses klarifikasi.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Melaksanakan analisis akar masalah (<i>Root Cause Analysis</i> / <i>RCA</i>) terhadap pelanggaran yang terjadi	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0

		untuk melihat keterkaitan antara kelalaian individu dan sistem kerja rumah sakit.				
		Menyusun surat rekomendasi formal kepada Direktur RS Prima Husada mengenai pemberian sanksi profesi (teguran tertulis, pembatasan kewenangan sementara, <i>proctoring</i> ulang) bagi yang terbukti bersalah, atau menerbitkan surat rekomendasi pemulihan nama baik (<i>rehabilitasi profesi</i>) jika staf tidak terbukti melakukan pelanggaran.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
5	Monitoring kepatuhan etika dan disiplin	Melakukan pemantauan harian terhadap kepatuhan staf di unit kerja mengenai kedisiplinan jam dinas dan penggunaan atribut identitas (<i>ID Card</i>) resmi sesuai aturan internal rumah sakit (<i>Non-Medical Staff Bylaws</i>).	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Mengembangkan dan mengevaluasi indikator perilaku profesional staf yang diintegrasikan ke dalam lembar Evaluasi Kinerja Profesional Berkelanjutan (<i>Ongoing Professional Practice Evaluation / OPPE</i>) setiap 6 bulan sekali.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Melakukan kunjungan berkala (<i>round audit</i>) ke unit-unit penunjang medis untuk memastikan iklim kerja tetap kondusif dan berjalan sesuai standar etika pelayanan rumah sakit.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
6	Komunikasi Efektif	Mengadakan pelatihan dan penyegaran tata cara komunikasi efektif bagi staf penunjang, khususnya dalam memberikan edukasi instruksi persiapan pra-tindakan kepada pasien (seperti instruksi puasa atau minum obat pencahar).	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Membina kemampuan staf Farmasi dalam melakukan Pemberian Informasi Obat (PIO) dan	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0

		konseling kepada pasien/keluarga secara ramah, jelas, dan empatik demi meningkatkan kepuasan pelayanan.				
		Memfasilitasi mediasi komunikasi interprofesi guna mencegah terjadinya salah paham atau konflik horizontal antar-staf penunjang maupun dengan profesi medis/keperawatan saat berkoordinasi klinis.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
7	Pembuatan kebijakan	Menyusun dan memperbarui buku panduan perilaku profesional (<i>Code of Conduct</i>) staf Tenaga Kesehatan Lain RS Prima Husada yang diselaraskan dengan regulasi hukum kesehatan terbaru.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Merumuskan draf Kebijakan Direktur dan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait alur pelaporan, investigasi, dan tata cara persidangan etik staf penunjang medis di rumah sakit.	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
		Melakukan evaluasi dan revisi berkala terhadap aturan internal staf non-medis (<i>Non-Medical Staff Bylaws</i>) agar tetap relevan dengan perkembangan organisasi dan tuntutan akreditasi rumah sakit (STARKES).	Internal	12 kali setahun	Rp. 0	Rp. 0
NO	NAMA DIKLAT	SASARAN	JENIS DIKLAT	KEBUTUHAN SATU TAHUN	HARGA SATUAN	
1	Komite Tenaga Kesehatan Lain	Anggota Komite Tenaga Kesehatan Lain	Eksternal	2	Rp. 0	Rp. 0
2	Mitra Bestari	Pengurus Komite Tenaga Kesehatan Lain	Eksternal	2	Rp. 0	Rp. 0
3	Manajemen Unit	Kepala Ruang	Eksternal	2	Rp. 0	Rp. 0
4	Penyegaran <i>Technical Skills</i> dan	Staf pelaksana fungsional KTKL yang berdasarkan rapor evaluasi (OPPE) atau hasil audit mutunya masih di bawah standar unit.	Internal	2	Rp. 0	Rp. 0

	Kepatuhan SPO Teknis Klinis					
GRAND TOTAL ANGGARAN						Rp. 0

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

4.1 MONITORING

1. Tujuan

- a. Memantau keterlaksanaan seluruh program kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain (KTKL) RS Prima Husada.
- b. Mengidentifikasi hambatan, risiko, dan kepatuhan tindak lanjut di masing-masing instalasi penunjang medis.
- c. Menjamin kesesuaian pelaksanaan pelayanan klinis penunjang dengan standar akreditasi rumah sakit (STARKES), regulasi internal (Non-Medical Staff Bylaws), dan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku.

2. Frekuensi monitoring

- a. Rutin Bulanan: Untuk kegiatan operasional harian di unit penunjang.
- b. Triwulan: Untuk evaluasi progres ketercapaian program kerja komite.
- c. Semester: Untuk pelaksanaan audit internal dan evaluasi kepatuhan regulasi profesi.
- d. Insidental: Dilakukan sewaktu-waktu apabila ditemukan temuan kritis, insiden keselamatan pasien berat, atau atas perintah langsung dari Direktur Rumah Sakit Prima Husada.

3. Metode Monitoring

- a. Review dokumen
 - 1) Data log pelaksanaan Kredensial dan Rekredensial KTKL.
 - 2) Bukti verifikasi digital STR Seumur Hidup di Portal SATUSEHAT SDMK.
 - 3) Bukti keikutsertaan pelatihan mandiri/CPD staf fungsional di platform Plataran Sehat.
 - 4) Rekapitulasi insiden keselamatan, pelanggaran etik-disiplin profesi, dan berkas tindak lanjutnya.
 - 5) Laporan mutu bulanan dari masing-masing unit kerja (Farmasi, Fisioterapi, Laboratorium, Radiologi, Gizi, Rekam Medis) serta tinjauan rekam jejak logistik dan pemeliharaan peralatan teknis penunjang secara berkala..
- b. Observasi lapangan
 - 1) Kepatuhan pelaksanaan Standar Prosedur Operasional (SPO) tindakan teknis diagnostik dan terapeutik di unit kerja.
 - 2) Kepatuhan penerapan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) pada pelayanan penunjang.
 - 3) Alur riil proses pelayanan pada jam sibuk (peak hours).
- c. Wawancara/ studi kasus
 - 1) Staf pelaksana fungsional KTKL (Apoteker, TTK, ATLM, Radiografer, Ahli Gizi, Perekam Medis, dan Fisioterapis).
 - 2) Kepala Instalasi / Penanggung Jawab Ruangan unit penunjang.
 - 3) Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lain (Dokter/Perawat) bila terkait kolaborasi lintas profesi.
- d. Pengukuran indikator
 - 1) Kepatuhan kebersihan tangan (hand hygiene) petugas penunjang.
 - 2) Kepatuhan identifikasi pasien secara tepat (SKP 1) sebelum sampling/paparan/pemberian obat.
 - 3) Ketepatan dan kelengkapan dokumentasi (misal: pengisian berkas rekam medis atau lembar asuhan gizi).
 - 4) Ketepatan waktu pelaporan nilai kritis laboratorium dan radiologi (SKP 2).

-
- 5) Jumlah kasus etik-disiplin profesi yang masuk ke meja komite.
4. Prosedur Monitoring
- a. Persiapan
 - 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring triwulanan/semesteran.
 - 2) Menetapkan indikator spesifik dan instrumen daftar tilik (checklist) monitoring unit penunjang.
 - 3) Menginformasikan jadwal pelaksanaan kepada para Kepala Instalasi terkait.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Mengumpulkan data laporan internal dari unit Farmasi, Fisioterapi, Lab, Radiologi, Gizi, dan Rekam Medis.
 - 2) Melakukan observasi langsung di lapangan sesuai dengan instrumen daftar tilik yang telah disiapkan.
 - 3) Melakukan verifikasi silang (cross-check) antara dokumen fisik/digital, hasil wawancara, dan observasi nyata.
 - 4) Mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian prosedur, akar masalah, serta potensi risiko klinis.
 - c. Analisis dan penilaian
 - 1) Menentukan kategori hasil temuan lapangan:
 - a) Kritis: Berdampak langsung pada keselamatan pasien, kesalahan fatal diagnosis/terapi, atau pelanggaran berat etik profesi.
 - b) Mayor: Ketidakpatuhan signifikan terhadap SPO teknis yang berpotensi memicu kerugian/cedera.
 - c) Minor: Ketidaksesuaian bersifat administratif atau prosedural ringan yang memerlukan perbaikan proses.
 - 2) Menyusun draf rekomendasi tindakan perbaikan sistem.
5. Indikator monitoring utama
- a. Persentase seluruh staf Tenaga Kesehatan Lain yang telah memiliki Surat Penugasan Klinis (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) aktif.
 - b. Kepatuhan pelaksanaan supervisi klinis harian oleh staf senior sesuai jadwal.
 - c. Tingkat keaktifan staf dalam pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) melalui diklat mandiri.
 - d. Jumlah total kasus aduan etik/disiplin profesi dan persentase penyelesaiannya melalui sidang Ad-Hoc.
 - e. Angka kepatuhan pengisian kelengkapan rekam medis, pelaporan nilai kritis, dan ketepatan distribusi berkas.
 - f. Persentase kepatuhan terhadap indikator mutu nasional (IMN) di masing-masing instalasi penunjang.

4.2 EVALUASI

- 1. Waktu pelaksanaan
 - a. Evaluasi Bulanan: Menilai progres capaian kegiatan operasional bulanan komite.
 - b. Evaluasi Triwulan: Menilai capaian program kerja gabungan dan tren grafik indikator mutu unit.
 - c. Evaluasi Semester: Menilai efektivitas implementasi penugasan klinis staf melalui instrumen OPPE (Evaluasi Kinerja Profesional Berkelanjutan).
 - d. Evaluasi Tahunan: Menilai keberhasilan dan hambatan keseluruhan program kerja Komite KTKL dalam satu tahun anggaran berjalan.

-
2. Metode evaluasi
 - a. Review indikator
 - 1) Kredensial
 - 2) Kepatuhan SPO
 - 3) Kepatuhan supervisi
 - 4) Mutu dokumentasi
 - 5) Angka Kejadian Insiden Keselamatan Pasien (KNC, KTD, KPC) di ruang penunjang medis.
 - b. Analisis
 - 1) Tren indikator
 - 2) Wawancara
 - 3) Fokus grup discusion dengan perawat, kepala ruang, sub komite
 - c. Audit internal
 - 1) Audit klinis
 - 2) Audit dokumen
 - 3) Audit implementasi standar
 - d. Penilaian capaian program
 - 1) Dibandingkan dengan target tahunan dan standar regulasi
 3. Prosedur evaluasi
 - a. Pengumpulan data
 - 1) Mengumpulkan seluruh dokumen laporan monitoring bulanan, triwulanan, dan semesteran.
 - 2) Mengumpulkan data indikator mutu nasional dan insiden keselamatan pasien yang berkorelasi dengan pelayanan KTKL.
 - 3) Mengumpulkan berkas laporan kinerja dari masing-masing Sub Komite (Kredensial, Mutu Profesi, Etik-Disiplin).
 - 4) Melakukan verifikasi kebenaran dan validitas data bersama para Kepala Instalasi penunjang.
 - b. Analisis pelaksanaan program
 - 1) Membandingkan realisasi program kerja riil Komite KTKL dengan draf rencana tahunan.
 - 2) Menghitung persentase tingkat capaian target program kerja.
 - 3) Menganalisis tingkat kesesuaian pelayanan dengan standar akreditasi rumah sakit (STARKES).
 - 4) Mengidentifikasi ketidaksesuaian alur, kendala operasional fungsional, dan risiko sistemik rumah sakit.
 - c. Penilaian efektifitas program
 - 1) Menilai kontribusi program kerja komite terhadap peningkatan mutu layanan penunjang secara riil di RS Prima Husada.
 - 2) Menilai dampak pengawasan komite terhadap perlindungan hukum praktik profesional staf dan keamanan pasien.
 - d. Penetapan temuan evaluasi
Klasifikasi temuan:
 - 1) Kritis : berdampak pada keselamatan pasien/ etik/ disiplin
 - 2) Mayor : pelanggaran signifikan terhadap SPO/ standar
 - 3) Minor : ketidaksesuaian yang tidak berdampak langsung
 - e. Penyusunan rekomendasi
 - 1) Membuat rekomendasi perbaikan spesifik dan terukur
 - 2) Menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan risiko
 - 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, revisi SPO atau perubahan prosedur
-

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

5.1 PENCATATAN

1. Jenis pencatatan
 - a. Pencatatan kegiatan rutin
 - 1) Rapat komite
 - 2) Kredensial dan rekredensial
 - 3) Supervisi klinis
 - 4) Audit mutu pelayanan klinis
 - 5) Pelatihan internal dan eksternal
 - b. Pencatatan indikator mutu
 - 1) Kepatuhan identifikasi pasien
 - 2) Kepatuhan hand hygiene
 - 3) Kepatuhan SPO
 - 4) Kepatuhan dokumentasi berkas
 - c. Pencatatan kasus etik dan disiplin
 - 1) Laporan kejadian
 - 2) Hasil telaah etik
 - 3) Tindak lanjut dan pembinaan
 - d. Pencatatan insiden keselamatan pasien
 - 1) Insiden keselamatan pasien
 - 2) Analisis akar masalah
 - 3) Rencana perbaikan
2. Prosedur pencatatan
 - a. Setiap kegiatan/ subkomite mencatat kegiatan pada form pencatatan.
 - b. Dokumen dicatat secara:
 - c. Dokumen disimpan dalam arsip fisik dan database digital.
 - d. Data direkap oleh sekretaris komite.

5.2 PELAPORAN

1. Jenis Laporan
 - a. Laporan bulanan
 - 1) Realisasi kegiatan
 - 2) Rekap insiden/ etik (jika ada)
 - b. Laporan triwulan
 - 1) Evaluasi pencapaian program
 - 2) Masalah dan rekomendasi
 - c. Laporan semester
 - 1) Efektivitas supervisi dan pembinaan
 - 2) Capaian program mutu profesi
 - d. Laporan tahunan
 - 1) Capaian seluruh program kerja
 - 2) Analisis indikator mutu
 - 3) Rekap kredensial dan rekredensial
 - 4) Rekap kasus etik dan tindak lanjut
 - 5) Rekomendasi untuk program kerja tahun berikutnya
2. Alur pelaporan
 - a. Masing-masing Ketua Subkomite mengirimkan dokumen laporan kegiatan yang telah disusun kepada Sekretaris Komite KTKL.
 - b. Sekretaris Komite KTKL mengolah, mengompilasi, dan menyusun laporan menjadi satu dokumen komprehensif per periode pelaporan (Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan).

-
- c. Ketua Komite KTKL melakukan verifikasi, peninjauan ulang, dan validasi data akhir untuk memastikan kesesuaian isi laporan dengan kondisi riil organisasi.
 - d. Dokumen laporan resmi yang telah ditandatangani oleh Ketua Komite KTKL disampaikan secara formal kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada untuk mendapatkan arahan kebijakan, disposisi tindak lanjut, dan pengesahan.

BAB VI PENUTUP

Program kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab dan pelayanan yang lebih baik

Pasuruan, 25 Desember 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns.,M.Kep

Ketua Komite Keperawatan



Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep

LAMPIRAN 1
RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS TENAGA TEKHNIS KEFARMASIAN

Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	
Pendidikan Formal	:	
Kompetensi Khusus	:	
Tanggal Kredensial	:	
<i>Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk melaksanakan tindakan sesuai dalam Rincian Kewenangan Klinis TENAGA TEKHNIS KEFARMASIAN</i> <i>Saya juga menyatakan kompeten untuk melakukan prosedur teknis seperti tercantum di bawah ini sebagai bagian dari kewenangan klinis (clinical privileges) berdasarkan status Kesehatan saat ini, Pendidikan dan atau pelatihan yang saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.</i>		
Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian dideskripsikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1335/2024 Tentang Standar Kompetensi Tenaga Vokasi Farmasi		
Kode Pengisian : - Mandiri - Dibawah Supervisi - Tidak diberi kewenangan		

No	Kompetensi	Assesmen Mandiri			Review Validasi		
		1	2	3	1	2	3
A	Melakukan pengkajian						
1	Menyiapkan obat sesuai etiket dan instruksi farmasis						
2	Melakukan pengecekan nama pasien, nama obat, dosis dan bentuk sediaan						
3	Memastikan kecocokan antara resep dan obat yang diserahkan						
4	Mengantarkan dan menyerahkan obat ke unit perawatan						
5	Mengidentifikasi kesesuaian obat yang diserahkan dengan daftar permintaan unit						
6	Menyusun dan mengelompokkan obat berdasarkan klasifikasi						
7	Menyimpan obat sesuai system FEFO dan persyaratan suhu dan kelembaban						
8	Menyiapkan dan mengantar obat ke unit pelayanan sesuai permintaan						
9	Mendistribusikan obat berdasarkan system unit dose						
10	Mencatat dan melaporkan penggunaan dan stok obat kepada apoteker						
11	Menyiapkan alat dan bahan untuk sediaan injeksi dan sediaan mat steril						
12	Membantu farmasis dalam menyiapkan ruang kerja steril dan alat						
13	Tidak melakukan pencampuran larutan secara mandiri						
14	Menggunakan peralatan proteksi personal atau Alat Pelindung Diri (APD) di laboratorium medik						

15	Memberikan label pada kemasan sekunder						
16	Mengemas obat racikan dengan standar keamanan dan informasi yang cukup						
17	Menyimpan data penggunaan obat, lobook dan laporan bulanan sesuai regulasi						
18	Mengidentifikasi dan mencatat obat kedaluwarsa atau rusak						
19	Mengumpulkan dan memilah limbah obat, serta menyerahkan ke pihak berwenang						

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS APOTEKER

Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	
Pendidikan Formal	:	
Kompetensi Khusus	:	
Tanggal Kredensial	:	
<i>Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk melaksanakan tindakan sesuai dalam Rincian Kewenangan Klinis APOTEKER</i> <i>Saya juga menyatakan kompeten untuk melakukan prosedur teknis seperti tercantum di bawah ini sebagai bagian dari kewenangan klinis (clinical privileges) berdasarkan status Kesehatan saat ini, Pendidikan dan atau pelatihan yang saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.</i>		
Kompetensi Apoteker dideskripsikan sesuai dengan PMK Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit		
Kode Pengisian : 1. Mandiri 2. Dibawah Supervisi 3. Tidak diberi kewenangan		

No	Kompetensi	Assesmen Mandiri			Review Validasi		
		1	2	3	1	2	3
1	Menerima, megevaluasi dan menganalisis resep dokter						
	a. Menilai kesesuaian indikasi, dosis, rute pemberian, frekuensi durasi terapi						
	b. Mendeteksi interaksi obat, kontraindikasi, duplikasi terapi, alergi obat						
	c. Menerima, megevaluasi dan menganalisis resep dokter						
2	Edukasi dan konseling obat						
	a. Memberikan informasi tentang penggunaan obat kepada pasien dan keluarga						
	b. Menjelaskan efek samping, cara penyimpanan, cara penggunaan obat						
	c. Melakukan konseling lanjutan untuk penyakit kronik						
3	Monitoring Terapi Obat (MTO)						
	a. Melakukan pemantauan terhadap efek terapeutik dan efek samping obat						
	b. Menilai kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan						
	c. Menyusun laporan Monitoring Efek Samping Obat (MESO)						
4	Intervensi Farmasi						
	a. Memberikan rekomendasi perubahan regimen terapi kepada dokter berdasarkan hasil monitoring						
	b. Melakukan intervensi atas masalah terkait obat						

	(Medication error, Drug related problems/DRP)						
5	Pelayanan Farmakovigilans						
	a. Melaporkan kejadian tidak diinginkan (Adverse Drug Reaction/ADR) ke instansi terkait						
	b. Mengidentifikasi dan menganalisis efek samping obat						
6	Pemberian obat dan penyuluhan						
	a. Memberikan obat sesuai dengan SOP dan ketentuan regulasi						

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	
Pendidikan Formal	:	
Kompetensi Khusus	:	
Tanggal Kredensial	:	
<i>Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk melaksanakan tindakan sesuai dalam Rincian Kewenangan Klinis Rekam Medis dan Informasi Kesehatan</i> <i>Saya juga menyatakan kompeten untuk melakukan prosedur teknis seperti tercantum di bawah ini sebagai bagian dari kewenangan klinis (clinical privileges) berdasarkan status Kesehatan saat ini, Pendidikan dan atau pelatihan yang saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.</i>		
Kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Rumah Sakit dideskripsikan sesuai dengan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan		
Kode Pengisian : 1. Mandiri 2. Dibawah Supervisi 3. Tidak diberi kewenangan		

No	Kompetensi	Assesmen Mandiri			Review Validasi		
		1	2	3	1	2	3
A. Manajemen data dan informasi kesehatan							
1	Merancang standar data kesehatan						
	a. Merancang elemen data						
	b. Merancang data set						
	c. Merancang struktur						
	d. Merancang isi data kesehatan						
2	Mengelola data dan informasi Kesehatan						
	a. Merancang dan penerapan keamanan data kesehatan						
	b. Mengelola pelepasan informasi kesehatan						
	c. Menyusun pelaporan pelayanan dan program kesehatan						
3	Memanfaatkan data dan informasi untuk menunjang pelayanan Kesehatan						
	a. Menggunakan statistic untuk perencanaan pelayanan dan program kesehatan						
	b. Menggunakan statistic untuk pemantauan indicator mutu, efisiensi dan produktifitas pelayanan dan program kesehatan						
	c. Menggunakan statistic sebagai informasi untuk pengambilan Keputusan manajemen pelayanan dan program kesehatan						
4	Menggunakan system informasi Kesehatan dalam pengelolaan data kesehatan						
	a. Menggunakan system dan aplikasi pengolahan data						
	b. Menggunakan system informasi kesehatan						
	c. Menggunakan system informasi rumah sakit						



	d. Memahami perancangan system informasi						
B. Keterampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah Kesehatan lainnya, serta prosedur klinis							
5	Memahami konsep klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah Kesehatan lainnya serta prosedur klinis						
	a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah Kesehatan lainnya serta prosedur klinis						
	b. Memahami struktur, karakteristik system klasifikasi klinis dan kodifikasi dan masalah Kesehatan lainnya serta prosedur klinis yang digunakan						
	c. Memahami jenis – jenis klasifikasi, kodifikasi penyakit dan masalah Kesehatan lainnya serta prosedur klinis						
6	Menggunakan berbagai jenis klasifikasi klinis, penyakit dan masalah Kesehatan lainnya serta prosedur klinis						
	a. Menggunakan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah Kesehatan lainnya seperti <i>International Statistical Clasification of Disease and Related Health Problem</i> (ICD) di rumah sakit						
	b. Menggunakan klasifikasi prosedur klinis seperti <i>International Clasification of Prosedure</i> di rumah sakit						
7	Memahami dan menggunakan system pembiayaan pelayanan Kesehatan yang menggunakan dasar klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah Kesehatan lainnya, serta prosedur klinis						
	a. Memahami system pembiayaan secara manual maupun elektronik						
	b. Menggunakan system pembiayaan secara manual maupun elektronik						
	c. Menganalisis system pembiayaan secara manual maupun elektronik						
	d. Mengevaluasi system pembiayaan secara manual maupun elektronik						
8	Memahami, membuat dan menyajikan statistic dari klasifikasipenyakit dan masalah Kesehatan lainnya serta prosedur klinis						
	a. Memahami statistic dari klasifikasi dan masalah Kesehatan lainnya, serta prosedur klinis						
	b. Membuat statistic dari klasifikasi dan masalah Kesehatan lainnya, serta prosedur klinis						
	c. Menyajikan statistic dari klasifikasi dan masalah Kesehatan lainnya, serta prosedur klinis						



	d. Menganalisis statistic dari klasifikasi dan masalah Kesehatan lainnya, serta prosedur klinis						
	e. Mengevaluasi statistic dari klasifikasi dan masalah Kesehatan lainnya, serta prosedur klinis						
C. Aplikasi statistic Kesehatan, epidemiologi dasar dan biomedik							
9	Mengumpulkan data pelayanan dan program Kesehatan secara manual dan elektronik						
10	Mengolah data pelayanan dan program Kesehatan secara manual dan elektronik						
11	Menyajikan data pelayanan dan program Kesehatan secara manual dan elektronik						
12	Menganalisis data pelayanan dan program Kesehatan secara manual dan elektronik						
13	Memanfaatkan data pelayanan dan program Kesehatan sebagai informasi/masukan untuk pengambilan keputusan						
	a. Memanfaatkan analisis data pemanfaatan pelayanan dan program kesehatan						
	b. Mengembangkan parameter mutu untuk digunakan dalam organisasi/institusi pengelola pelayanan dan program kesehatan						
	c. Memanfaatkan data bagi pengembangan pelayanan kesehatan						
	d. Memanfaatkan data bagi pengembangan program kesehatan						
	e. Memanfaatkan data untuk pendidikan dan penelitian pelayanan dan program kesehatan						
D. Manajemen pelayanan RMIK							
14	Mengelola pelayanan RMIK dengan berbagai media						
	a. Mengelola pelayanan RMIK manual						
	b. Mengelola pelayanan RMIK hybrid						
	c. Mengelola pelayanan RMIK elektronik						
15	Mengelola pelayanan RMIK di rumah sakit						
16	Mengelola mutu pelayanan RMIK						
	a. Memahami konsep mutu pelayanan RMIK						
	b. Menggunakan indicator mutu pelayanan RMIK						
	c. Memanfaatkan indicator mutu pelayanan RMIK untuk meningkatkan kualitas						
17	Menjaga privasi, keamanan dan kerahasiaan data dan informasi						
	a. Mengatur hak akses membuka RMIK sesuai dengan kewenangan individu						
	b. Memperoleh surat kuasa dari pasien sebelum melepaskan informasi-nya ke pihak yang berkepentingan						

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS AHLI GIZI

Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	
Pendidikan Formal	:	
Kompetensi Khusus	:	
Tanggal Kredensial	:	
<i>Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk melaksanakan tindakan sesuai dalam Rincian Kewenangan Klinis AHLI GIZI</i> <i>Saya juga menyatakan kompeten untuk melakukan prosedur teknis seperti tercantum di bawah ini sebagai bagian dari kewenangan klinis (clinical privileges) berdasarkan status Kesehatan saat ini, Pendidikan dan atau pelatihan yang saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.</i>		
Kompetensi Ahli Gizi dideskripsikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1910/2022 Tahun 2022 tentang Standar Profesi Gizi		
Kode Pengisian : 1. Mandiri 2. Dibawah Supervisi 3. Tidak diberi kewenangan		

No	Kompetensi	Assesmen Mandiri			Review Validasi		
		1	2	3	1	2	3
1	Melakukan pengkajian masalah gizi dan dietetic pada berbagai kondisi klinis secara kolaboratif dengan tenaga Kesehatan lain						
2	Penegakan diagnosis gizi dan dietetic sesuai dengan Terminologi Proses Asuhan Gizi Terstandar						
3	Melakukan asuhan gizi dan dietetic yang sesuai dengan kondisi klinis dan kemampuan penerima pelayanan gizi dan dietetic, serta ketersediaan bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan						
4	Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan terhadap indicator dan outcome asuhan gizi dan dietetic						
5	Membangun sinergi dan kolaborasi dengan nakes lain untuk mendapatkan hasil pelayanan gizi dan dietetic yang optimal						
6	Merancang standar makanan diet untuk pemenuhan kebutuhan diet penerima pelayanan gizi dan dietetic sesuai kondisinya						
7	Merancang kebutuhan jumlah dan jenis bahan pangan yang diperlukan untuk pengelolaan makanan diet						
8	Merancang jenis dan komposisi makanan diet (termasuk kuliner dietetic dan bahan pangan fungsional) yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan diet penerima pelayanan gizi dan dietetic sesuai kondisi dan ketersediaan bahan pangan						
9	Menyajikan makanan diet sesuai kebutuhan penerima pelayanan gizi dan dietetic individu dan komunitas secara efektif dan efisien						



10	Menjaga standar mutu bahan yang digunakan dan produk makanan diet yang dihasilkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan sesuai kondisi penerima pelayanan gizi dan dietetik						
11	Mengelola sumberdaya manusia sesuai prinsip pengembangan SDM						
12	Mengelola anggaran yang digunakan pada penyelenggaraan makanan diet yang efektif dan efisien						
13	Mengelola sarana dan prasarana pengolahan makanan diet sesuai prinsip – prinsip keamanan pangan dan keselamatan						
14	Berkolaborasi dengan tenaga Kesehatan lain untuk pengolahan dan penyediaan makanan diet dalam jumlah besar secara efektif dan efisien						
15	Mengelola masalah gizi dan dietetic pada Tingkat individu dan komunitas						
16	Mengintegrasikan output penyelenggaraan makanan diet dalam proses asuhan gizi dan dietetic pada Tingkat individu dan komunitas						
17	Menetapkan dan menganalisis indicator dan outcome keberhasilan pelayanan gizi dan dietetic serta penyelenggaraan makanan diet penerima pelayanan gizi dan dietetic pada sasaran individu, komunitas dan institusi fasilitas pelayanan Kesehatan						
18	Melakukan analisis dan merumuskan hasil penelitian dan kajian terapan bidang gizi dan dietetic termasuk pemanfaatan pangan fungsional pada Tingkat individu dan komunitas						
19	Mengadvokasi dan membuat usulan rekomendasi kebijakan institusi fasilitas pelayanan Kesehatan dan komunitas berdasarkan laporan pelayanan dan hasil penelitian/kajian bidang gizi dan dietetic sesuai kondisi social, ekonomi, budaya dan lingkungan						

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS FISIOTERAPI

Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	
Pendidikan Formal	:	
Kompetensi Khusus	:	
Tanggal Kredensial	:	
<i>Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk melaksanakan tindakan sesuai dalam Rincian Kewenangan Klinis ANALIS LABORATORIUM</i> <i>Saya juga menyatakan kompeten untuk melakukan prosedur teknis seperti tercantum di bawah ini sebagai bagian dari kewenangan klinis (clinical privileges) berdasarkan status Kesehatan saat ini, Pendidikan dan atau pelatihan yang saya jalani serta pengalaman yang saya miliki..</i>		
Kompetensi Analis Laboratorium dideskripsikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/313/2020 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik.		
Kode Pengisian : 1. Mandiri 2. Dibawah Supervisi 3. Tidak diberi kewenangan		

No	Kompetensi	Assesmen Mandiri			Review Validasi		
		1	2	3	1	2	3
A	Melakukan pengkajian						
1	Mengolah specimen untuk pengujian						
2	Melakukan proses pengujian						
3	Melakukan Teknik pengujian						
4	Melakukan pelaporan dan validasi hasil						
5	Mengolah specimen untuk pengujian						
B	Melakukan Interpretasi hasil secara analitik						
1	Melakukan hubungan antara hasil pengujian, diagnosis, informasi klinis dan terapi berdasarkan ; nilai rujukan, nilai kritis, keterbatasan metode, hasil yang tidak mungkin, kondisi klinis dan hasil pengujian lainnya						
2	Melakukan penggabungan antara hasil pengujian dengan kriteria pengendalian mutu internal						
3	Melakukan investigasi terhadap hasil yang tidak lazim/tidak masuk akal						
4	Menilai normal tidaknya hasil analisa untuk dikonsultasikan kepada berwenang						
C	Melakukan Penjaminan Mutu						
1	Melakukan penilaian kelayakan hasil proses serta melakukan tindakan perbaikan dari pemantapan mutu internal						
2	Melakukan penilaian kelayakan hasil proses serta melakukan tindakan perbaikan dari pemantapan mutu eksternal						
3	Melakukan identifikasi jenis kesalahan dalam pengujian laboratorium						
4	Melakukan validasi / verifikasi alat metode dan atau reagen meliputi : uji persisi, akurasi,						



	banding, korelasi, recovery, linieritas, limit deteksi, nilai rujukan						
D	Melakukan Keamanan kerja dan pasien safety						
1	Menggunakan peralatan proteksi personal atau Alat Pelindung Diri (APD) di laboratorium medik						
2	Melakukan aplikasi praktik hygiene dan pengontrolan infeksi di lingkungan kerja						
3	<i>Menggunakan alat safety dengan baik (biosafety cabinet, safety, shower, dan lain – lain)</i>						
4	Melakukan pemilihan dan penggunaan desinfeksi dan alat sterilisasi sesuai dengan kebutuhan						
5	Melakukan tindakan darurat kebakaran di lingkungan kerja						
6	<i>Melakukan Point of Care Test</i>						
7	Melaksanakan pelayanan darah dan tranfusi meliputi, permintaan, penyimpanan, tes kecocokan datah dan distribusi darah sesuai dengan prosedur yang berlaku						
E	Mengelola Masalah Kesehatan berbasis Laboratorium						
1	Melakukan promosi Kesehatan berbasis Laboratorium						
2	Mengidentifikasi kebutuhan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku, serta modifikasi gaya hidup untuk promosi Kesehatan Masyarakat, jenis kelamin, etnis dan budayaberbasis laboratorium pada berbagai kelompok umur, agama,						
3	Merencanakan dan melakukan pendidikan Kesehatan berbasis Laboratorium dalam Irangka promosi pelayanan Laboratorium medik di Tingkat individu dan masyarakat						
4	Melakukan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah Kesehatan pada individu dan Masyarakat berbasis Laboratorium						
5	Melakukan penatalaksanaan masalah Kesehatan berbasis Laboratorium medik terhadap individu dan masyarakat						
F	Mengelola Bank Darah Rumah Sakit						
1	Menerima darah yang sudah di uji saring oleh UTD						
2	Menyimpan darah dan memantau persediaan darah						
3	Melakukan uji silang serasi darah pendonor dan darah pasien						
4	Melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan golongan darah ABO/ rhesus ke UTD secara berjenjang						
5	Menyerahkan darah yang cocok bagi pasien di rumah sakit						
6	Melacak penyebab reaksi tranfusi atau kejadian ikutan akibat						

	tranfusi darah yang tidak layak pakai ke UTD untuk dimusnahkan						
7	Mengembalikan darah yang tidak layak pakai ke UTD untuk dimusnahkan						

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS RADIOGRAFER

Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	
Pendidikan Formal	:	
Kompetensi Khusus	:	
Tanggal Kredensial	:	
Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk melaksanakan tindakan sesuai dalam Rincian Kewenangan Klinis RADIOGRAFER Saya juga menyatakan kompeten untuk melakukan prosedur teknis seperti tercantum di bawah ini sebagai bagian dari kewenangan klinis (clinical privileges) berdasarkan status Kesehatan saat ini, Pendidikan dan atau pelatihan yang saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.		
Kompetensi Radiografer dideskripsikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/316/2020 Tentang Standar Profesi Radiografer.		
Kode Pengisian : 1. Mandiri 2. Dibawah Supervisi 3. Tidak diberi kewenangan		

No	Kompetensi	Assesmen Mandiri			Review Validasi		
		1	2	3	1	2	3
A	Tindakan pemeriksaan Radiografi Konvensional Non Kontras						
1	Kepala rutin						
2	Kepala khusus						
3	Vertebrae						
4	Rongga dada						
5	Abdomen						
6	Pelvis						
7	Tulang ekstremitas atas						
8	Tulang ekstremitas bawah						
9	Panoramik						
B	Tindakan pemeriksaan radiografi konvensional dengan kontras						
C	Tindakan pemeriksaan CT Scan non kontras						
1	Kepala umum						
2	Kepala khusus						
3	Leher						
4	Vertebrae						
5	Thorax						
6	Abdomen						
7	Pelvis						
8	Ekstremitas atas						
9	Ekstremitas bawah						
D	Tindakan pemeriksaan CT Scan dengan kontras						
1	Kepala umum						
2	Kepala khusus						
3	Leher						
4	Vertebrae						
5	Thorax						

6	Abdomen						
7	Pelvis						
8	Ekstremitas atas						
9	Ekstremitas bawah						
E	Tindakan pemeriksaan USG						
1	USG Abdomen						
2	USG Gynekologi						
3	USG Thyroid						
4	USG Testis						
5	USG Mammae						
6	USG Thorax dasar						
7	USG Muskuloskeletal						
8	USG Vaskuler						
9	USG Pediatrik						
F	Tindakan pemeriksaan intervensional (DSA dan C-Arm)						
1	Kepala						
2	Leher						
3	Vertebrae						
4	Thorax						
5	Abdomen						
6	Ekstremitas atas						
7	Ekstremitas bawah						

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS

Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	
Pendidikan Formal	:	
Kompetensi Khusus	:	
Tanggal Kredensial	:	
<i>Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk melaksanakan tindakan sesuai dalam Rincian Kewenangan Klinis ANALIS LABORATORIUM</i> <i>Saya juga menyatakan kompeten untuk melakukan prosedur teknis seperti tercantum di bawah ini sebagai bagian dari kewenangan klinis (clinical privileges) berdasarkan status Kesehatan saat ini, Pendidikan dan atau pelatihan yang saya jalani serta pengalaman yang saya miliki..</i>		
Kompetensi Analis Laboratorium dideskripsikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/313/2020 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik.		
Kode Pengisian : 1. Mandiri 2. Dibawah Supervisi 3. Tidak diberi kewenangan		

No	Kompetensi	Assesmen Mandiri			Review Validasi		
		1	2	3	1	2	3
A	Melakukan pengkajian						
1	Mengolah specimen untuk pengujian						
2	Melakukan proses pengujian						
3	Melakukan Teknik pengujian						
4	Melakukan pelaporan dan validasi hasil						
5	Mengolah specimen untuk pengujian						
B	Melakukan Interpretasi hasil secara analitik						
1	Melakukan hubungan antara hasil pengujian, diagnosis, informasi klinis dan terapi berdasarkan ; nilai rujukan, nilai kritis, keterbatasan metode, hasil yang tidak mungkin, kondisi klinis dan hasil pengujian lainnya						
2	Melakukan penggabungan antara hasil pengujian dengan kriteria pengendalian mutu internal						
3	Melakukan investigasi terhadap hasil yang tidak lazim/tidak masuk akal						
4	Menilai normal tidaknya hasil analisa untuk dikonsultasikan kepada berwenang						
C	Melakukan Penjaminan Mutu						
1	Melakukan penilaian kelayakan hasil proses serta melakukan tindakan perbaikan dari pemantapan mutu internal						
2	Melakukan penilaian kelayakan hasil proses serta melakukan tindakan perbaikan dari pemantapan mutu eksternal						
3	Melakukan identifikasi jenis kesalahan dalam pengujian laboratorium						
4	Melakukan validasi / verifikasi alat metode dan atau reagen meliputi : uji persisi, akurasi,						



	banding, korelasi, recovery, linieritas, limit deteksi, nilai rujukan						
D	Melakukan Keamanan kerja dan pasien safety						
1	Menggunakan peralatan proteksi personal atau Alat Pelindung Diri (APD) di laboratorium medik						
2	Melakukan aplikasi praktik hygiene dan pengontrolan infeksi di lingkungan kerja						
3	<i>Menggunakan alat safety dengan baik (biosafety cabinet, safety, shower, dan lain – lain)</i>						
4	Melakukan pemilihan dan penggunaan desinfeksi dan alat sterilisasi sesuai dengan kebutuhan						
5	Melakukan tindakan darurat kebakaran di lingkungan kerja						
6	<i>Melakukan Point of Care Test</i>						
7	Melaksanakan pelayanan darah dan tranfusi meliputi, permintaan, penyimpanan, tes kecocokan datah dan distribusi darah sesuai dengan prosedur yang berlaku						
E	Mengelola Masalah Kesehatan berbasis Laboratorium						
1	Melakukan promosi Kesehatan berbasis Laboratorium						
2	Mengidentifikasi kebutuhan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku, serta modifikasi gaya hidup untuk promosi Kesehatan Masyarakat, jenis kelamin, etnis dan budayaberbasis laboratorium pada berbagai kelompok umur, agama,						
3	Merencanakan dan melakukan pendidikan Kesehatan berbasis Laboratorium dalam Irangka promosi pelayanan Laboratorium medik di Tingkat individu dan masyarakat						
4	Melakukan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah Kesehatan pada individu dan Masyarakat berbasis Laboratorium						
5	Melakukan penatalaksanaan masalah Kesehatan berbasis Laboratorium medik terhadap individu dan masyarakat						
F	Mengelola Bank Darah Rumah Sakit						
1	Menerima darah yang sudah di uji saring oleh UTD						
2	Menyimpan darah dan memantau persediaan darah						
3	Melakukan uji silang serasi darah pendonor dan darah pasien						
4	Melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan golongan darah ABO/ rhesus ke UTD secara berjenjang						
5	Menyerahkan darah yang cocok bagi pasien di rumah sakit						
6	Melacak penyebab reaksi tranfusi atau kejadian ikutan akibat						

	tranfusi darah yang tidak layak pakai ke UTD untuk dimusnahkan						
7	Mengembalikan darah yang tidak layak pakai ke UTD untuk dimusnahkan						

LAMPIRAN 2

**DAFTAR KLASIFIKASI PELANGGARAN ETIK DAN DISIPLIN
(Komite Tenaga Kesehatan Lain RS Prima Husada Sukorejo)**

Tingkat Pelanggaran	Objek Tanggung Jawab	Jenis Pelanggaran
Pelanggaran Ringan (Skor 1 – 30)	Tanggung jawab terhadap pasien	1. Tidak menyapa pasien saat awal kontak pelayanan di unit penunjang (Laboratorium/Radiologi/Farmasi/Gizi/Rekam Medis). 2. Tidak memperkenalkan nama dan peran sebelum melakukan tindakan pelayanan penunjang. 3. Berbicara dengan nada kurang ramah atau kurang empatik saat memberikan instruksi persiapan pemeriksaan atau konseling obat/gizi. 4. Kurang mendengarkan keluhan atau pertanyaan pasien secara aktif. 5. Respons lambat terhadap antrean pasien yang tidak bersifat gawat darurat. 6. Tidak menjelaskan tindakan pelayanan penunjang sederhana yang akan dilakukan (misal: posisi foto rontgen, area penusukan jarum lab, atau aturan minum obat). 7. Kurang menjaga privasi pasien (misal: tidak menutup tirai pembatas saat pengambilan sampel darah, pemeriksaan rontgen portabel, atau wawancara gizi/rekam medis). 8. Bahasa tubuh atau ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksabaran menghadapi pasien/keluarga. 9. Berbicara hal pribadi atau bercanda berlebihan dengan sesama rekan di depan pasien yang sedang mengantre pelayanan. 10. Meninggalkan pasien tanpa penjelasan setelah tindakan pelayanan selesai. 11. Tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami pasien saat memberikan edukasi klinis/instruksi medis.
	Tanggung jawab terhadap tugas	1. Datang terlambat masuk dinas di unit penunjang tanpa alasan yang jelas. 2. Pulang lebih awal sebelum jam dinas berakhir tanpa izin atasan/kepala instalasi. 3. Tidak mengikuti briefing atau handover (operan) sif tepat waktu. 4. Seragam dinas tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan atribut RS Prima Husada. 5. Tidak menggunakan tanda pengenal resmi (ID Card) saat bertugas melayani pasien. 6. Lupa mengisi sebagian formulir administrasi di unit kerja. 7. Tidak menjaga kerapian, kebersihan, dan higienitas area kerja penunjang. 8. Menggunakan ponsel pribadi saat jam kerja untuk kepentingan non-dinas hingga mengabaikan antrean pelayanan.

		9. Tidak mematuhi tata tertib internal unit (misalnya aturan jam istirahat bergantian).
	Tanggung jawab terhadap sesama staf dan profesi lain	1. Tidak menyapa atau bersikap kurang sopan kepada rekan satu profesi maupun profesi lain (Dokter/Perawat). 2. Komunikasi kurang efektif atau kurang jelas saat melakukan operan sif (handover) di unit penunjang. 3. Nada bicara kurang menghargai rekan kerja lintas profesi saat berkoordinasi klinis. 4. Tidak menghormati pendapat atau masukan rekan sejawat terkait penanganan sampel/resep/berkas pasien. 5. Kurang kooperatif dalam kerja tim unit penunjang tanpa menghambat keselamatan pelayanan. 6. Mengabaikan etika komunikasi antarprofesi (misalnya menyela pembicaraan profesi lain saat koordinasi pasien). 7. Tidak membantu rekan kerja saat beban antrean pelayanan unit meningkat tanpa alasan yang sah.
	Tanggung jawab terhadap profesi	1. Kurang menjaga citra rumpun profesinya dalam sikap dan tutur kata sehari-hari di rumah sakit. 2. Berperilaku kurang profesional di lingkungan kerja penunjang medis. 3. Tidak mematuhi etika berpakaian profesi di luar area klinis saat membawa nama rumah sakit. 4. Kurang aktif mengikuti kegiatan pengembangan profesional internal yang dijadwalkan komite. 5. Mengeluh berlebihan tentang profesi atau kebijakan internal unit di lingkungan kerja. 6. Tidak menjaga etika berinteraksi di media sosial terkait hal-hal internal rumah sakit. 7. Kurang menghormati simbol, atribut, atau identitas organisasi profesi maupun rumah sakit.
Pelanggaran Sedang (Skor 31 – 70)	Tanggung jawab terhadap pasien	1. Tidak menjelaskan instruksi persiapan pra-tindakan secara lengkap (misal: instruksi puasa lab, minum pencahar radiologi, atau kepatuhan antibiotik) sehingga pasien salah paham. 2. Tidak memberikan edukasi dasar informasi obat (PIO) atau konseling gizi sesuai kebutuhan pasien. 3. Mengabaikan keluhan atau efek samping ringan pasien setelah tindakan penunjang dilakukan yang seharusnya ditindaklanjuti. 4. Tidak menghormati hak pasien untuk bertanya mengenai detail biaya, hasil penunjang, atau menolak tindakan non-emergency. 5. Kelalaian dalam memantau kondisi pasien selama tindakan penunjang berlangsung (misal: pasien lemas saat rontgen atau pingsan pasca-ambil darah). 6. Pelanggaran kerahasiaan data pasien secara terbatas (misal: meletakkan berkas rekam

		medis atau hasil lab di area yang bisa dibaca pengunjung umum tanpa unsur pidana). 7. Kesalahan prosedur teknis ringan yang tidak menimbulkan cedera serius pada pasien. 8. Penundaan pelayanan penunjang (penyerahan obat/hasil lab/berkas RM) yang berdampak pada ketidaknyamanan signifikan bagi pasien. 9. Tidak mematuhi prinsip Sasaran Keselamatan Pasien (misal: mengabaikan identifikasi ganda nama & tanggal lahir pasien sebelum tindakan).
	Tanggung jawab terhadap tugas	1. Tidak menjalankan SPO pelayanan klinis penunjang yang berdampak pada terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (KNC/KTD/KPC) non-sentinel. 2. Melakukan tindakan penunjang berisiko sedang tanpa koordinasi atau konfirmasi ulang dengan penanggung jawab unit. 3. Dokumentasi rekam medis pasien atau lembar asuhan profesi tidak lengkap dan dilakukan secara berulang-ulang. 4. Kesalahan penyiapan sediaan obat, salah baca resep, atau salah label sampel/foto yang beruntung tertangkap sebelum diserahkan ke pasien (tanpa cedera). 5. Tidak melaksanakan prosedur handover (operan) berkas atau alat sesuai ketentuan tertulis. 6. Tidak melaporkan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) tingkat ringan-sedang yang terjadi di unitnya secara sengaja. 7. Menunda-nunda pelaksanaan tugas krusial (seperti validasi hasil, distribusi berkas RM, atau penyerahan obat cito) tanpa alasan jelas. 8. Melaksanakan tugas pelayanan di luar batas rincian kewenangan klinis (RKK) yang dimilikinya namun belum menimbulkan dampak cedera berat. 9. Mengabaikan instruksi kerja tertulis dari Kepala Instalasi atau Direksi yang sah. 10. Kelalaian dalam menjaga keamanan, pembersihan, atau pencatatan penggunaan alat-alat medis/analisis penunjang.
	Tanggung jawab terhadap sesama staf dan profesi lain	1. Komunikasi tidak efektif saat pelaporan nilai kritis laboratorium/radiologi sehingga menimbulkan penundaan tatalaksana oleh dokter/perawat. 2. Tidak menyampaikan data atau informasi klinis penting pasien kepada petugas penunjang di sif berikutnya. 3. Mengabaikan rekomendasi atau catatan klinis dari profesi lain yang relevan bagi asuhan pasien. 4. Menyalahkan rekan kerja atau profesi lain secara terbuka di area publik atau di depan pasien/keluarga. 5. Menyampaikan kritik atau ketidakpuasan kerja dengan cara tidak profesional yang menyulut konflik internal unit.

		- Menolak bekerja sama dalam pelayanan koordinasi pasien lintas profesi tanpa alasan yang sah. - Menggunakan bahasa atau sikap yang merendahkan kompetensi rumpun profesi lain di rumah sakit.
	Tanggung jawab terhadap profesi	- Tidak mematuhi pedoman perilaku profesional KTKL dalam praktik sehari-hari. - Mengabaikan kewajiban pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) atau perpanjangan STR yang menjadi tanggung jawab mandiri. - Menolak mengikuti pembinaan profesi atau konseling preventif yang dijadwalkan oleh Sub Komite Etik. - Menggunakan atribut profesi atau fasilitas pelayanan rumah sakit secara tidak pantas di ruang publik. - Berperilaku tidak profesional di media sosial dengan mengunggah keluhan operasional pelayanan yang mencoreng citra RS Prima Husada. - Mengabaikan rekomendasi standar praktik yang ditetapkan oleh komite mutu profesi.
Pelanggaran Berat (Skor 71 – 100)	Tanggung jawab terhadap pasien	- Kelalaian berat dalam pelayanan penunjang medis yang menyebabkan cedera fisik serius, kecacatan, atau kematian pasien. - Melakukan tindakan klinis penunjang yang secara nyata tidak sesuai indikasi medis dan keselamatan pasien. - Melakukan kekerasan fisik, verbal, atau psikologis secara nyata terhadap pasien di area pelayanan. - Melakukan pelecehan seksual atau tindakan asusila terhadap pasien. - Bersikap diskriminatif secara ekstrem menolak memberikan pelayanan penunjang berdasarkan suku, ras, agama, atau status sosial pasien. - Mengabaikan atau menolak melayani permintaan pemeriksaan/obat pasien dalam kondisi gawat darurat (cito) tanpa alasan medis. - Melakukan tindakan invasif atau pemeriksaan berisiko tinggi tanpa adanya kompetensi/RKK yang sah sehingga membahayakan pasien. - Pemalsuan, manipulasi, atau perekrasan data klinis pasien (misal: merekrasan hasil laboratorium, memalsukan eksisi radiologi, atau memanipulasi riwayat rekam medis). - Membocorkan rahasia kedokteran atau rekam medis pasien ke pihak luar/media sosial yang menimbulkan kerugian material maupun moral bagi pasien. - Menghentikan sepihak atau menunda pelayanan kritis pasien tanpa instruksi medis tertulis dari dokter penanggung jawab.
	Tanggung jawab terhadap tugas	Meninggalkan tugas dinas (mangkir) di unit pelayanan kritis tanpa keterangan sah yang menyebabkan kekosongan pelayanan dan memicu insiden fatal.

		- Melakukan praktik klinis penunjang secara mandiri di luar batas kewenangan klinis (RKK) yang secara sadar diketahuinya melanggar hukum. - Penyalahgunaan, penggelapan, atau transaksi ilegal obat-obatan (terutama narkotika/psikotropika), alat medis, atau fasilitas berharga rumah sakit. - Pemalsuan tanda tangan dokter, verifikator, atau pejabat rumah sakit dalam dokumen rekam medis, resep, atau klaim pelayanan. - Mengabaikan SPO pelayanan secara sengaja demi kecepatan/kepentingan pribadi yang berakibat fatal (sentinel event). - Salah menyerahkan obat konsumsi dosis tinggi (High Alert) atau salah menginput golongan darah hasil laboratorium yang berakibat fatal bagi pasien. - Tidak melaporkan insiden keselamatan pasien kategori berat (sentinel) secara sengaja untuk menutupi kesalahan individu. - Menghilangkan, merusak, atau menyabotase alat biomedis bernilai tinggi atau server rekam medis elektronik (EMR) akibat kelalaian ekstrem. - Melaksanakan tugas pelayanan dalam kondisi fisik/mental tidak layak (misal: di bawah pengaruh alkohol, narkoba, atau zat psikotropika). - Menolak melaksanakan tugas penunjang darurat dalam situasi bencana atau krisis rumah sakit tanpa alasan yang sah.
	Tanggung jawab terhadap sesama staf atau profesi lain	- Melakukan kekerasan fisik, pemukulan, atau ancaman pembunuhan serius terhadap rekan sejawat atau profesi lain di lingkungan RS. - Melakukan pelecehan seksual atau perundungan berat (bullying) secara terstruktur di tempat kerja penunjang. - Melakukan sabotase hasil kerja rekan sejawat (misal: merusak sampel lab, mengubah setelan dosis radiologi rekan, atau menghapus resep) sehingga membahayakan pasien. - Menyembunyikan kesalahan fatal rekan kerja secara sengaja yang dapat mengancam nyawa pasien. - Menyampaikan fitnah, berita bohong, atau tuduhan palsu yang merusak reputasi profesional rekan kerja atau profesi lain secara luas. - Menghalangi komunikasi atau koordinasi lintas profesi secara sengaja dalam situasi pelayanan gawat darurat. - Penyalahgunaan jabatan struktural untuk menekan, memeras, atau merugikan staf penunjang bawahannya.
	Tanggung jawab terhadap profesi	Menjalankan praktik pelayanan penunjang di rumah sakit tanpa memiliki STR dan/atau Surat Izin Praktik (SIP/SIPR/SIPA/SIPTG) yang sah/berlaku.

		2. Meminjamkan atau menggunakan dokumen perizinan (STR/SIP) milik orang lain untuk mengelabui proses kredensial. 3. Pemalsuan dokumen profesi (ijazah, STR, SIP, sertifikat kompetensi pelatihan, atau rekayasa jumlah logbook tindakan) saat mengajukan kredensial. 4. Melakukan tindakan kriminal pidana dengan memanfaatkan status atau fasilitas profesinya di rumah sakit. 5. Pelanggaran berat kode etik nasional profesi masing-masing yang mencoreng kepercayaan publik secara luas terhadap rumah sakit. 6. Menghambat, mengintervensi, memberikan keterangan palsu, atau menolak putusan sidang Majelis Etik dan Disiplin Komite secara sengaja. 7. Menyebarkan informasi palsu (hoax) medis atau menyalahgunakan nama RS Prima Husada untuk kepentingan komersial pribadi ilegal.
--	--	--